



SOTSIAALMINISTEERIUM



EESTI PUUETEGA INIMESTE KODA
ESTONIAN CHAMBER OF PEOPLE WITH DISABILITIES



Kaasrahasanud
Euroopa Liit



Eesti
tuleviku heaks



Terviseprobleemiga laste ja nende perede toetamise hea tava

TALLINN 2025

Väljaandja:

Sotsiaalministeerium

Suur-Ameerika 1

Tallinn 10122

Telefon: +372 626 9301

Faks: +372 626 9209

info@sm.ee

Juhendmaterjal on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Mitmekülgse abivajadusega lastele teenuste väljatöötamine ja arendamine” raames.

Juhendmaterjali koostajad: Katrin Tsuiman, Helle Känd, Sirje Norden, Siiri Rannama koos Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga, Kerti Kollom Seidelberg, Maarja Krais-Leosk ja Kristi Kähär.

Kujundus: Tauno Asuja

Toimetus: Kristi Kallaste

Trükis: ISBN 978-9949-9505-8-4

Elektroniline väljaanne (pdf): ISBN 978-9949-9505-9-1

Sisukord

Eessõna.....	4
Sissejuhatus.....	5
AMETNIKU SEKKUMISE EETIKA.....	6
1. Tegevused, millega näitad, et töötad eetilisel ja lähtud lapse ja pere heaolust.....	6
2. Suhtlemisuskused, mis toetavad abivajadusega last ja tema peret.....	9
3. Lapse kaasamise olulisus.....	12
4. Pere olemasolevate ressursside kaardistamine.....	14
5. Vanemate toetamine, jõustamine ja ja suunamine uute oskuste omandamisele (sh enesehoiule).....	16
6. Kokkuvõte.....	18
MÕLEMA SILMA PIMEDUS.....	20
1. Tervise seisundist üldisemalt.....	20
2. Suhtlemine pimedaga lapsega.....	21
3. Kuidas toetada pimedat last ja tema peret?.....	22
4. Õppe kohandamisega seotud baasvajadused.....	24
5. Lisainfo.....	26
INTELLEKTIPUUE.....	27
1. Tervise seisundist üldisemalt.....	27
2. Suhtlemine intellektipuudega lapsega.....	28
3. Kuidas toetada intellektipuudega last ja tema peret?.....	30
4. Õppe kohandamisega seotud baasvajadused.....	32
5. Lisainfo.....	33
HARVIKHAIGUSED.....	34
1. Tervise seisundist üldisemalt.....	34
2. Harvikaiguste esinemissagedus ja spetsiifika.....	35
3. Harvikaigusega lapse ja pere toetamine.....	36
4. Suhtlemine harvikaigusega lapsega.....	38
5. Vajalik info, teenused, toetused ja muu abi.....	38
6. Õppe kohandamisega seotud baasvajadused.....	40
7. Lisainfo.....	41
AUTISMI RASKEMAD VORMID (AUTISM JA INTELLEKTIPUUE).....	42
1. Tervise seisundist üldisemalt.....	42
2. Suhtlemine autismispektri häirega ja intellektipuudega lapsega.....	43
3. Kuidas toetada last ja tema peret?.....	45
4. Õppe kohandamisega seotud baasvajadused.....	53
5. Lisainfo.....	53
DOWNI SÜNDROOM.....	54
1. Tervise seisundist üldisemalt.....	54
2. Suhtlemine Downi sündroomiga lapsega.....	55
3. Kuidas toetada Downi sündroomiga last ja tema peret?.....	55
4. Õppe kohandamisega seotud baasvajadused.....	57
5. Lisainfo.....	57
VÄHI DIAGNOOSID.....	58
1. Tervise seisundist üldisemalt.....	58
2. Suhtlemine vähihaige lapsega.....	59
3. Kuidas toetada vähihaiget last ja tema peret?.....	59
4. Õppe kohandamisega seotud baasvajadused.....	61
5. Lisainfo.....	62

Eessõna

Käesolevat juhendmaterjali ajendas looma vajadus toetada endisest veelgi paremini pikaajalise haiguse või erivajadusega lapsi ja nende peresid. Juhendmaterjal on mõeldud eeskätt lastega töötavatele spetsialistidele, võimaldamaks viimastel abistada peresid, kes peavad igapäevaselt seisma silmitsi keerukate olukordadega ja langetama oma last puudutavaid olulisi otsuseid.

See raamat aitab spetsialistil paremini mõista laste erivajadusi, toetada peresid professionaalselt ja samas empaatiliselt ning juhendada oma töös nii kutse-eetikast kui ka kasulikest kogemustest. Tänu sellele suureneb tõenäosus, et terviklik abi jõuab erivajadusega lasteni võimalikult kiirelt ja hõlpsalt.

Materjal koondab endas teabe, mis seni on olnud kättesaadav üpris hajusalt. Süsteemne ülevaade aitab uutel spetsialistidel teemades kiiresti orienteeruda ning kogenumatel oma teadmisi ja lähenemisi täiendada. Erinevate terviseprobleemide käsitlused, praktilised näited ning ametniku eetika peatükk muudavad selle materjali igapäevatöös oluliseks tööriistaks.

Autoritena soovime, et see asjatundliku koostöö ja pikaajalise kogemuse viljana sündinud raamat aitaks kasvatada mõistmist ning tugevdada usaldust ja koostööd kõigi osapoolte vahel ning leiaks rohket kasutust nii nüüd kui ka tulevikus.

Merileid Vinkler
Laste heaolu teenuste nõunik
Sotsiaalministeerium

Sissejuhatus

Hea lapse ja perega töötav spetsialist

Kui perre sünnib erivajadusega laps või kui lapsel kujuneb elu jooksul tervisest tingitud abivajadus, seisab pere silmitsi uue ja sageli keeruka olukorraga. Spetsialisti/ametniku tegevused tervisest tingitud abivajadusega lapse ja tema pere toetamisel peavad põhinema teadlikkusel ja eetilistel põhimõtetel, mis toetavad inimväärikust, turvatunnet ja koostööd. See eeldab oma rolli ja selle olulisuse mõistmist, selget tegutsemist lapse ja pere parimate huvide nimel ning ausat, lugupidavat ja hinnanguvaba suhtlusviisi.

Nende eesmärkide nimel on siia juhendmaterjali koondatud:

- praktilisi näiteid, mille kaudu puudega laps ja tema pere tajuvad, et sinu tegutsemine ametnikuna on eetiline, hooliv ja koostööpõhine;
- kuue erineva tervises seisundi ülevaated;
- põhimõtted ja võimalused toetamaks tervisest tingitud abivajadusega last ja tema peret.

Millistel juhtudel võid siit juhendmaterjalist kasu leida:

- oled alustav spetsialist või alles õpid;
- oled praktiseeriv spetsialist ja otsid uusi teadmisi, toetust või soovid saada kinnitust töö käigus omandatud kogemustele;
- sinuga on kontakti võtnud vanem, kelle lapsel esineb mõni juhendis käsitletud haigus või erivajadus ja sa sooviksid saada selle kohta rohkem teavet.

Juhendmaterjali koostamise juures on nõu ja jõuga abiks olnud puuetega laste vanemad, pikka aega praktiseerinud hoolekandespetsialistid ning huvikaitseorganisatsioonide esindajad. Niivõrd laiapõhjaline kollektiiv varustab sind loodetavasti kindlustundega, et just selliste põhimõtete järgi, nagu nende kaante vahele kirja pandud, loodavad üks laps ja ta pere näha sind end abistamas.

Juhendmaterjalile andsid tänuväärset tagasisidet Elen Kokla, Triinu Limbak (Setomaa vallavalitsuse sotsiaalosakond), Maris Oolu (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet), Sille Tohver (Pärnu Linnavalitsuse lastekaitseteenistus), Marje Oona (Eesti Perearstide Selts), Chris Pruunsild (Eesti Lastearstide Selts), Marianne Kuzemtšenko (Eesti Autismiliit), Piret Liba (Haridus- ja Teadusministeerium) ja Terje Luude (Jüri Kool).

Ametniku sekkumise eetika

Hea lapsega töötav spetsialist, hoia alati meeles see, et kõik sinu **tegevused peavad lähtuma lapse parimast huvist ja pere heaolust** ning tuleb läbi viia professionaalselt, neutraalselt ja asjaosaliste eneseväärikust riivamata.

Praktikas tähendab ülaltoodud põhimõtte järgimine seda, et vanem:

- on alati oma lapse parim ekspert;
- koos lapsega on koostööpartner, kes on kaasatud kõikidesse lapsega seotud otsustusprotsessidesse;
- eeldab, et oled asjatundja ja oskuslik kuulaja, kes tugineb otsustusprotsessis ainult faktilisele teabele, sh lapsega kokku puutunud erialaspetsialistide hinnangutele ja arvamustele.

Praktikas tähendab see ka seda, et:

- igal tegevusel on eesmärk ning sa oled selle vajalikkuse endale teadvustanud ja põhjendanud;
- sinu keelekasutus on last ja peret toetav; väldid keelekasutust, mis võib mõjuda süüdistavalt või hinnanguliselt;
- sa kaasad alati pere ja lapse aruteludesse ja otsuste tegemisse, kui see on võimalik ja sobiv;
- Teadvusta, et pere võib tajuda, et oled spetsialistina nendega suhtluses võimupositsioonil. Kogu suhtlus ja tegutsemine suuna pere elukvaliteedi toetamiseks.

1. TEGEVUSED, MILLEGA NÄITAD, ET TÖÖTAD EETILISELT JA LÄHTUD LAPSE JA PERE HEAOLUST

1.1. ALUSTA TURVALISE SUHTLUSKESKKONNA LOOMISEST

Praktikas tähendab see, et:

- Planeeri endale piisavalt aega perega vestlemiseks – ära katkesta ega kiirusta.
- Pöördu lapse poole nimepidi ja tutvusta ennast ka lapsele, mitte ainult vanema(te)le.
- Enne kohustuslikke ametlikke menetlussamme ja abimeetmete arutelu loo perega turvaline ja usalduslik kontakt. Suhte loomisel on oluline nii verbaalne kui mitteverbaalne suhtlusviis. Kasuta lauseid, mis näitavad, et pere vaade on enne sinu vaatenurka: "Aitäh, et leidsite aja kohtumiseks. Alustame sellest, et räägite oma vaatenurgast. Minu jaoks on oluline seda mõista."

Nii näitad, et ei vaata peret „juhtumina“, vaid inimestena, kellega koos tehakse otsuseid.

1.2. UURI PERE HINNANGUT OMA ELULE JA OLUKORRALE

Praktikas tähendab see, et:

- Sa arvestad, et pere tunnetus oma olukorrast on väärtuslik.
- Küsi ja tunne huvi: „Millal te viimati tundsite, et teil oli päriselt kergem?“ või: „Mis teie meelest teid praegu kõige rohkem toetaks?“
- Sa ei sea pereliikme sõnu kahtluse alla lihtsalt seetõttu, et need ei ühti sinu käsutuses olevate dokumentidega, teiste spetsialistide käest kuulduga või isiklike veendumustega.

Nii tunneb pere, et neid mõistetakse, mitte ei hinnata. Vanemad saavad olla oma olukorrast rääkides ausad ja nad ei tunne, et peavad „ennast tõestama“.

1.3. SELGITA OMA OTSUSEID JA TEGEVUSI LÄBIPAISTVALT JA LIHTSAS KEELES

Praktikas tähendab see, et:

- Kasutad keelt ja sõnu, mis ei sisalda erialast terminoloogiat ega slängi.
- Aitad toetaval ja mõistval viisil saada aru dokumentides olevast erialasest ja ametlikust tekstist: "Mõistan, et see taotlus/vorm/hinnang võib tunduda keeruline. Võime koos üle vaadata, mis seal kirjas on (mida sinna kirja panna) ja miks seda küsitakse."
- Mõistad, et olemasolevad lahendused ei ole alati selged ja üheselt mõistetavad. Selgitad ja avad otsuseid, hoides fookuses inimese vaadet: "See toetus/lahendus võib tunduda sobiv, aga vaatame koos, kuidas see teid päriselt toetab."

Nii on perel võimalus tajuda, et sa ei tee asju „enda moodi“, vaid aitad neil süsteemis orienteeruda. See loob usaldust ja aitab vältida võõrandumist abist ja teenustest.

1.4. HINDA OTSUSTE MÕJU LAPSE JA PERE IGAPÄEVAELULE

Praktikas tähendab see, et:

- Tunned huvi, mida otsused päriselt kaasa toovad, küsides: „Kui me selle teenuse/toetuse otsustame, kuidas see teie igapäevaelu mõjutab?“
- Mõttele kaasa, mida tehtud otsus veel tähendada võib: kas see tähendab perele lisakoormust, transporti, ajakulu? „Kui hakkaksite seda teenust kasutama, siis kas teil oleks aega ja transporti sinna jõudmiseks?“
- Kohanda oma soovitusi, mh vaata ka väljapoole oma teenuste piire, kui mõni teenus on sisuliselt sobimatu.
- Uuri: „Millist toetust te tunnete vajavat, et saaksite iseseisvalt jätkata?“

Nii näitad, et mõtled ka praktilise koormuse ja mõjude peale ega eelda, et igasugune abi on alati kasulik. Tänu sellele tunneb pere, et neile ei pakuta lahendusi, mis ei toimi või mida nad ei suuda kasutada.

1.5. VÄLDI SÜÜDISTAVAT JA HINNANGULIST KEELT – KESKENDU LAHENDUSTELE, MITTE PUUDUSTELE

Praktikas tähendab see, et:

- Raja suhe usaldusele ja mõlemapoolsele koostööle.
- Sa usud, et ühine koostöö perega aitab leida pere jaoks kõige sobivamad lahendused.
- Toetad, otsid võimalusi ja juhendad inimest, kuidas liikuda edasi vajalike tegevustega perele võimalikult hõlpsal viisil.
- Vältid sõnastust, mis toovad välja puudusi ja rõhutavad inimese poolt tegemata jätmisi. Toetad tegevusi ja otsid võimalusi, kuidas jõuda abisaamisele lähemale. Nt väldi lauset: "Teil on vajalikud dokumendid puudu ja see on probleem."
- Lausu nt: "Dokumentidele on veel vaja lisada seda ja seda – vaatame koos, kuidas need saada."
- Sa ei vihja inimese eluolukorras tehtud hilinenud otsustele, vaid võtad asju nii nagu need hetkel on. Välti lauseid, mis vihjavad abi hilinemisele, nt: "Te oleks pidanud varem pöörduma." Keskendu käesolevale hetkele ning näita võimalusi olukorda muuta. Lausu nt: „Praegu oleme siin ja vaatame edasi."

Nii vähendad peres häbitunnet ja hirmu ning teie suhe jääb tuginema koostööle, mitte hindamistele.

1.6. ARVESTA LAPSE VAADET JA SEISUNDIT – MITTE AINULT VANEMATE SEISUKOHTI

Praktikas tähendab see, et:

- Räägid lapsega otse kui võimalik, või kaudsemalt mängu, joonistamise või piltide kaudu.
- Küsid näiteks: „Kuidas sulle meeldib päev, kui oled kodust eemal?“
- Märkad lapse kehalisi ja emotsionaalseid reaktsioone, ei suru peale oma suhtlemist ega otsi iga hinna eest kontakti.

Nii näitad, et laps ei ole teie suhtluses passiivne objekt, vaid oluline osapool ja laps tunneb, et tema arvamus ja tunded loevad.



1.7. PAKUD PERELE PÄRAST OTSUSE TEGEMIST JÄRELKOHTUMIST VÕI SUUNAD EDASI VAJALIKU TÖÖTAJA VÕI ABIVÕIMALUSE JUURDE

Praktikas tähendab see, et:

- Annad perele teada, et võtad kaasvastutuse tehtud otsuse üle ning oled kättesaadav, kui perel tekivad raskused. Lausud näiteks: "Kui see otsus on tehtud, võite mulle paari nädala pärast märku anda, kuidas teil läheb. Vaatame siis koos edasi."
- Kui sa ise ei jätkata või ei saa jätkata, selgitad selle põhjuseid ja suunad pere järgmise kontakti juurde. Jälgi, et pere jaoks ei algaks uut menetlust, vaid see oleks jätk juba tehtud tööle. Lausu näiteks: „Teiega hakkab tegelema Mari, kellega oleme juba infot jaganud.“

Nii annad perele julgustust, et keegi on nendega teekonnal kaasas ja pere ei tunne, et nad jäeti „üksinda süsteemiga“.

1.8. MÄRKAD, KUI LAPSEL EI OLE OMA PERES HEA JA TURVALINE OLLA

Selleks on olemas mitmed praktilised juhendid [Lasteabi.ee tööriistakastis](https://lasteabi.ee/tooriistakastis), mis aitavad abivajadust märgata.

2. SUHTLEMISOSKUSED, MIS TOETAVAD ABIVAJADUSEGA LAST JA TEMA PERET

Töötades ja suheldes abivajadusega lapse ja tema perega peab suhtlemine **hoidma ülal turvatunnet, lootust, koostööd ja väärikut**. Seda toetavad spetsiifilised teadmised ja suhtlemisoskused nagu traumateadlikkus, positiivsus, lahenduskesksus ja hinnanguvabadus, mis aitavad tajuda suhtlemist eetilise ja jõustavana.

Praktikas tähendab see, et:

- Sa küsid enne tundliku teema käsitlemist pere valmisolekut sellel teemal tänasel kohtumisel vestelda.
- Kasutad neutraalset ja toetavat keelt: "Räägime koos, mida saaksime edasi teha."
- Pead lugu inimese elukogemusest ja austad valusaid emotsionaalseid reaktsioone, ei katkesta kedagi ega suru ennast peale.
- Pakud infot suuliselt ja kirjalikult, arvestades pereliikmete võimalikku stressiseisundit.

TEGEVUSED, MILLEGA NÄITAD, ET SUHTLED TOETAVALT:

2.1. TRAUMATEADLIKKUS

Mis see on?

Traumateadlikkus tähendab arusaamist, et inimesed võivad olla elus kogenud olukordi, mis on jätnud neile psühholoogilise või emotsionaalse jälje. Traumateadlik suhtleja ei too esile ebaturvalisi kogemusi, ei suru vastuseid peale ning arvestab, et stress mõjutab mõtlemist, mälu ja usaldust.

Praktikas tähendab see, et:

- Räägid rahulikult ja ei suru küsimusi peale. Lausud näiteks: „Võtame aega. Kui te ei soovi praegu vastata, siis pole sellest midagi.“
- Annad inimesele kontrollitunde tagasi: „Millal soovite sellest rääkida? Kas teile sobib rääkida siin või mujal? Kas soovite, et keegi oleks teiega kaasas?“
- Tunnustad läbielatut ilma survestamata: „Te olete selles olukorras palju kandnud. Räägime, mida saaksime teha, et see oleks teie jaoks kergem.“
- Väldid tarbetult šokeerivaid või korduvtraumatiseerivaid kirjeldusi ja küsimusi.
- Lubad vestluses pause: „Kas soovite korraks hinge tõmmata? Võime siinkohal peatuda.“

Nii tunneb pere, et neid ei survestata, ei alandata ning neil on turvaline rääkida või mõne teema osas hetkel vaikida.

2.2. POSITIIVSUS

Mis see on?

Positiivsus ei tähenda probleemide ilustamist või nende mahavaikimist, vaid suhtleja võimet hoida fookust tugevustel, võimalustel ja edasiviivatel sammudel – eriti just rasketes oludes. See annab lootust ja aitab säilitada motivatsiooni.

Praktikas tähendab see, et:

- Märkad edusamme ja pere pingutusi. Lausud näiteks: „Olete lapse jaoks juba palju teinud. Kas te ise märkate, kui palju see kõik tähendab?“
- Väldid vestluses ja kirjalikes tekstides negatiivsete siltide kasutamist (nt „hoolimatu“, „lootusetu“). Kasutad neutraalseid ja jõustavaid sõnu („vajab tuge“, „otsib lahendusi“).
- Leiad üles lootuse isegi keerulises olukorras. Lausud näiteks: „Kuigi see olukord on praegu raske, on meil mõned head võimalused, mida saame uurida.“
- Naeratad, kui sobib – hoiad sooja ja sõbralikku tooni.
- Sa ei alaväärista ega vähenda probleeme, vaid keskendud sellele, mis on hoomatav, pere poolt kontrollitav ja muudetav vajadusel koos sobiva abiga.

Nii tunneb pere, et olukord on küll keeruline, aga mitte lootusetu ning keegi näeb neis ka jõudu, mitte ainult nõrkusi.

2.3. LAHENDUSKESKSUS

Mis see on?

Lahenduskesksus tähendab keskendumist sellele, mis töötab, mida on võimalik teha, ja millised väikesed sammud viivad edasi või hoiavad tagasi olukorra halvenemist. Suhtleja ei takerdu ainult probleemidesse, vaid aitab inimestel paigalt liikuda ja vaadata tulevikku.

Praktikas tähendab see, et:

- Sa küsid: „Mis on varem toiminud?“ või: „Millal oli viimane kord, kus olukord oli parem?“
- Pakud ja otsid valikuid, ei jää kinni ainult ühte võimalikku lahendusse. Lausud näiteks: „Meil on paar võimalust – vaatame koos, kumb võiks sobida.“ Kindlasti on olemas ka võimalusi, mis jäävad tavapärastest teenustest väljapoole – mõelge neile koos ja arutlege ka tavalistest raamidest välja.
- Ära keskendu ainult sellele, mis on „puudu“ või „valesti“, vaid küsi ka: „Mis on teie tugevus?“ või: „Millised võrgustiku liikmed võiksid samuti kaasa rääkida?“
- Tunnusta väikeseid samme ja võite: „See, et te siia tulite ja räägite, on juba suur samm.“
- Aita sõnastada oodatavaid tulemusi ja lahendusi: „Milline oleks teile hea tulemus? Mida soovite kolme kuu pärast teistmoodi tunda või kogeda?“

Nii tunneb pere, et ei takerduta üksnes raskustesse, vaid on olemas ka lahendusi ning keegi usub, et muutus on võimalik.

2.4. HINNANGUVABADUS

Mis see on?

Hinnanguvabadus tähendab, et suhtleja ei hinda inimest moraalselt ega võrdle „normaalsuse“ järgi. Ta kuulab, mõistab ja ei tee oletusi välimuse, sotsiaalse tausta, mineviku või käitumise põhjal.

Praktikas tähendab see, et:

- Sa ei näita oma emotsioone ja ei reageeri halvustavalt, kui vanem ütleb: „Ma lihtsalt ei jaks enam.“ Sa saad vastata: „See on väga inimlik tunne. Räägime, kuidas saaksime teid selles olukorras toetada.“
- Sa ei kasuta vestluses lauseid: „Te oleksite pidanud...“ või „Miks te varem ei...“, vaid küsid: „Mis teie elus varem oli? Mis takistas varem abi otsimast?“
- Sa ei võrdle peret teistega. Sa saad vähendada pere enda poolt loodud häbitunnet. Saad öelda: „Iga pere on erinev ning meie roll on kuulata ja kohanduda just teie vajadustega.“
- Arvesta pereliikmete kultuurilise, keelelise ja emotsionaalse taustaga, ilma neid kritiseerimata – see on nende eluolu ja seda tuleb austada.
- Käitunud sama väärikalt kõigi pereliikmetega, sõltumata nende sotsiaalsest rollist või eneseväljendusest.
- Nii tunneb pere, et neid võetakse tõsiselt ja võrdselt ning ei peeta kehvaks, rumalaks ega vastutavaks oma lapse haiguse või puude eest.

3. LAPSE KAASAMISE OLULISUS

Töötades abivajadusega lapse ja tema perega tuleb arvestada, et lapsel on **õigus olla informeeritud ja vanusekohaselt kaasatud temaga seotud otsustesse**. See tähendab oskust luua lapsele sobiv kontakt, kuulata teda arvestavalt ja võtta tema arvamus otsuste langetamisse päriselt kaasa.

Praktikas tähendab see lapse vanusele, arengutasemele ja olukorrale vastaval moel:

- temaga kontakti loomist;
- tema arvamuse ja kogemuse ärakuulamist;
- tema seisukoha arvestamist teda puudutavate otsuste tegemisel.

See ei ole lihtsalt "lapse käest küsimine", vaid lapse nägemine ja kohtlemine täisväärtusliku subjektina, kellel on õigus osaleda.

TEGEVUSED, MILLEGA NÄITAD, ET LAPS ON KAASATUD

3.1. SUHTLE LAPSEGA OTSE, MITTE AINULT VANEMA KAUDU

Praktikas tähendab see, et:

- Tutvustad end lapsele ja võtad kontakti lapsele arusaadaval viisil. Lausud näiteks: „Tere, mina olen Kadi. Vaatame koos, kuidas sul läheb ja mida sa vajad.“
- Kasutad lapsele arusaadavat keelt, kasutad tema vanusele sobivat sõnavara või vahendeid ja väldid keerulist ametnikusõnavara. Lausud näiteks: „Kuidas sulle meeldib käia seal mängutoas?“, mitte: „Kuidas hindad oma osalemist rehabilitatsiooniteenuses?“
- Kui laps ei räägi, kasutad teisi meetodeid kontakti saavutamiseks – joonistamine, pildid, mäng, valikvastused.

Nii tunneb laps, et temaga arvestatakse otse, mitte vaid läbi vahendajate ja filtrite, ning ta on oma elus ise osaline.

3.2. UURI LAPSE ARVAMUST JA OOTA VASTUST – ÄRA KIIRUSTA EGA TÄIENDA ISE LAPSE ÕELDUT

Praktikas tähendab see, et:

- Loo turvaline ruum: istu lapsega samale tasandile; kuula, vaatle ja pane tähele, millele lapse tähelepanu ruumis kinnitub, nimeta seda oma vestluses; vestle loomulikus olekus, ära ole pealetükkiv, ära anna juhiseid, kuidas või mis on õige.
- Küsi: „Mis sulle selles mängus/tegevuses meeldib? Mis mitte?“ Ja oota vastust, isegi kui see tuleb väga aeglaselt või katkendlikult.

Nii tunnevad laps ja ta pere, et lapse ja pere arvamus loeb. Laps tunneb, et ta ei pea rääkima „õigesti“, „täiskasvanulikult“, et teda kuulataks.

3.3. VÕTA LAPSE ARVAMUS ARVESSE JA VIITA SELLELE OTSUSTES

Praktikas tähendab see, et:

- Ütle vanemale: „Lapse arvates on X keskkond talle kõige turvalisem. Vaatame, kas saame sellega arvestada.“
- Kui lapse arvamus ei saa otsust muuta, selgita, mis on selle tinginud. Lausu näiteks: „Ma kuulsin, et sa sooviksid koduõpet, aga seadus lubab seda ainult teatud juhtudel. Sellegipoolest mõtleme, kuidas koolis olemist mugavamaks teha.“

Nii tunneb laps oma sõnade peegeldamist ja kajastamist. Selles on sõnum „me kuulame ja arvestame sinuga“, mitte lihtsalt „me räägime lapsega“.

3.4. HINDAD LAPSE SUUTLIKKUST OSALEDA JA KOHANDAD KAASAMIST VASTAVALT

Praktikas tähendab see, et:

- Kui lapsel on intellektipuue, kasuta lihtsustatud keelt või pildimaterjale, nt tunnete kaarte, "meeldib/ei meeldi" valikuid, mängulisi ja loovaid vahendeid.
- Lühendad kohtumist, kui laps on väsinud – ei kiirusta ja ei pressi infot välja.
- Küsid ja kaasad peret kui infoallikat lapse harjumuste uurimiseks: „Millal ja kuidas laps paremini avaneb? Kuidas soovite, et lapsega räägin – kas esmalt ainult lapsega või koos?“

Nii tunnevad pere ja laps, et arvestatud on lapse tegeliku võimekuse ja heaoluga, mitte ei võeta kaasamist formaalse kohustusena.

3.5. SA EI PANE LAPSELE LIIGSET VASTUTUST EGA SURVET „ÕIGESTI VASTATA“

Praktikas tähendab see, et:

- Kinnitad lapsele, et pole olemas õiget ega valet, vaid on olemas erinevad mõtted ja mõnikord ei olegi mõtteid. Lausud näiteks: „Ükski vastus ei ole vale. Sa võid ka öelda, kui ei tea.“
- Kui laps ei soovi rääkida, aktsepteeri seda. Lausud näiteks: „Täna ei pea midagi ütlema. Sa võid lihtsalt siin olla ja kuulata.“
- Ära tee lapse vaikimisest või ebamugavast vastusest probleemi ega kiirusta sellest mööda. Võta seda kui tavalist hetke ja olukorda, sest elus esineb erinevaid situatsioone – ka neid, mis võivad täiskasvanule tunduda häirivad.

Nii tunneb laps ja pere, et kaasamine ei ole sund ega testide tegemine, vaid võimalus, mille tempo ja vorm arvestab lapse vajadusi.

4. PERE OLEMASOLEVATE RESSURSSIDE KAARDISTAMINE

Abistamise kõrval tuleb märgata ja tugevdada ka pere sisemisi ja nende ümber olevaid kogukondlikke ressursse. See on lähenemisviis, mis väljendab lugupidamist, partnerlust ja usku sellesse, et pere ei ole ainult abi saaja, vaid ka suutlik tegutseja.

TEGEVUSED, MILLEGA NÄITAD, ET LAPS ON KAASATUD

4.1. ÄRA ALUSTA „PUUDUSTEST“, VAID KÜSI, MIS SENI TOIMINUD ON

Praktikas tähendab see, et:

- Küsid perelt avatud viisil: „Millised lahendused on teil seni toimunud?“ või: „Kes on olnud teile seni toeks?“
- Küsid lapse toimekuse kohta: „Millal tundsite, et tal oli lihtsam? Mis selle võimaldas?“
- Uuri, mida pere juba oskab ja suudab, kuidas ta hakkama saab. Ära eelda, et „abi“ tuleb ainult väljastpoolt.

Nii tunneb pere, et nende kogemust ja pingutust hinnatakse, nad ei pea kõike nullist alustama: „Me pole abitud – meil juba on olemas midagi, mis loeb!“

4.2. UURI TEADLIKULT PERE OLEMASOLEVAID TOETAJAJAID JA VÕRGUSTIKKU

Praktikas tähendab see, et:

- Küsid: „Kas teil on keegi, kellega räägite, kui asjad lähevad raskeks?“
- Uurid, kas perel on sugulasi, naabreid, õpetajaid või teisi lähedasi isikuid, keda nad usaldavad.
- Lood koostöös visuaalse tugikaardi (nt joonis pere lähisuhetest ja toetajatest).
- Märka pere võimeid. Ehita perekonda abistav tugisüsteem juba olemasolevale vundamendile ning jõusta olemasolevaid ressursse.

Nii tunneb pere, et nende suhted ja lähedased on väärtuslikud, mitte „segavad tegurid“. Pere toetajate kaasamine pole märk nõrkusest, vaid tugevus.



4.3. MÄRKA JA NIMETA VANEMA VÕI LAPSE OSKUSI JA TUGEVUSI

Praktikas tähendab see, et:

- Jõustad ja aidad perel teadvustada oma ressursse. Lausu näiteks: „Kui peaksite end kirjeldama kui vanemat, siis mis oleks teie tugevus?“ „See, et te olete hoolduskohustuste kõrval suutnud last aidata kooliasjades, on suur asi.“
- Märkad lapse oskusi ja võimekust. Igaühel on midagi, mida ta suudab ja oskab. Lausu näiteks: „Tal on väga hea mälu“, või: „Tal on tähelepanelik silmavaade. Kas olete seda varem märganud?“

Nii tunneb pere, et neid nähakse kui võimekaid inimesi, mitte ainult kui abivajajaid.

4.4. PEA OLUKORRA KAARDISTAMIST KOOSTÖÖKS, MITTE KÜSITLEMISEKS

Praktikas tähendab see, et:

- Vii vestlust läbi kui avatud dialoogi, mitte kui ankeedi täitmist. Lausu näiteks sissejuhatuseks: „Räägime, mis on seni hästi toiminud, ja milles vajate tuge.“
- Näita, et pere arvamus loeb. Lausu näiteks: „Selle põhjal, mida te räägite, tundub, et teil on tugev peresisese toetuse võrgustik.“ või: „Selle põhjal, mida te räägite, tundub, et teil on olnud tõhus ajaplaneerimine ja suur enesekontroll.“
- Anna tagasipeegeldusi pere öeldust, kasuta sõnastusi nagu: „Te olete öelnud, et naabriga saab arvestada – see on oluline.“

Nii tunneb pere, et nendega räägitakse inimestena, mitte ei tehta küsitlust. Mõlema poole jaoks on tähtis tajuda, et neil on kaasvastutus, mitte ainult ootused teisele poolele.

4.5. ANNA PERELE VÕIMALUS ISE PRIORITEEDID SEADA

Praktikas tähendab see, et:

- Kaasa pere lahenduste loomisesse. Küsi perelt, mis on praegu kõige olulisem. Lausu näiteks: „Kui mõelda teie elu olukorrale tervikuna – mis vajaks kõige kiiremat lahendust?“
- Võimalda perel vabalt otsustada ja kaasa mõelda ka piiratud võimaluste raames, uurides pere valikuid. Lausu näiteks: „Kui teil oleks ainult üks tugi valida, mis aitaks kõige rohkem?“

Nii tunneb pere, et nende vajadused ei ole ainult „süsteemi järgi“ määratud – „Me saame ise hinnata, mis on meie jaoks kõige olulisem.“

5. VANEMATE TOETAMINE, JÕUSTAMINE JA SUUNAMINE UUTE OSKUSTE OMANDAMISELE (SH ENESEHOIULE)

Vanemate heaolu ja enesetõhusus on lapse heaolu eeldus ning ametniku ülesanne on vanemaid toetada, mitte asendada. Vanema toetamine tähendab nende pingutuste, teadmiste ja kogemuste teadvustamist ja väärtustamist. Kui vanem tunneb end nähtuna, väärtustatuna ja teadlikumalt tegutsejana, kandub see edasi ka lapsele, mõjutades tema heaolu positiivselt.

TEGEVUSED, MILLEGA NÄITAD VANEMA TOETAMIST, JÕUSTAMIST JA SUUNAMIST UUTE OSKUSTE OMANDAMISELE

5.1. MÄRKA JA TUNNUSTA VANEMA SENISEID PINGUTUSI

Praktikas tähendab see, et:

- Tunnustad vanemaid pingutuste eest ja aidad teadvustada, mida nad on juba hästi teinud.
- Ütlled vanematele siiralt ja konkreetselt: „Te olete olnud oma lapsele väga oluline tugi. Näen, et olete palju teinud, et tal oleks turvaline.“
- Ei alusta hinnangutega, vaid mõistmisega, lausudes näiteks: „Raske on abi otsida, kui kogu aeg tuleb ise hakkama saada.“

Nii tunneb pere, et neid märgatakse kui hoolivaid ja tegutsevaid vanemaid, mitte kui läbikukkunud abivajajaid ning nad saavad tunda end inimväärseks, mitte hindamise objektina.

5.2. UURI, MILLISED TEADMISED JA OSKUSED VANEMAL JUBA ON

Praktikas tähendab see, et:

- Uurid ja arvestad teadmisi, mis vanematel on. Lausu näiteks: „Milliseid toetavaid võtteid olete ise lapsega suheldes kasutanud?“
- Kaardistad, millistest allikatest on vanem oma teadmisi kogunud. Tunne huvi, kas vanem juba osaleb või on varem osalenud mõnel koolitusel, teraapias, saanud nõustamist.
- Tunnustad ja väärtustad vanemate teadmisi ja omandatud toimetulekuviise: „Teie lapsega suhtlemise viis näitab, et olete väga tähelepanelik tema vajaduste suhtes.“
- Nii tunneb pere, et nende olemasolevaid teadmisi ei alavääristata, nad ei pea kõike uuesti õppima ning neid peetakse võimekateks oma oskusi edasi arendama.

5.3. MÄRKA JA NIMETA VANEMA VÕI LAPSE OSKUSI JA TUGEVUSI

Praktikas tähendab see, et:

- Suhtle vanemaga kui partneriga: „On olemas üks peredele mõeldud koolitus, mis on saanud head tagasisidet. Soovite, et uurin selle kohta rohkem?“
- Kasuta suhtlemisel toetavat keelt, mitte survestades ja kohustades: „See võiks olla üks võimalustest, kuidas veelgi paremini toime tulla.“

Nii tunneb pere, et neile ei anta „retsepti“, vaid pakutakse arenguvõimalust ning ei õpetata ülevalt alla, vaid kaasatakse õppimisprotsessi.

5.4. UURI JA TOETA VANEMA ENESEHOIU VAJADUSI

Praktikas tähendab see, et:

- Oled taktitundeline ja tunned huvi tema kui inimese vastu. Küsi toetavalt: „Kuidas teil endal praegu läheb? Kas leiate hetki puhkuseks? Millal saite viimati puhata?“
- Ära sunni rääkima, kuid loo ruumi teemadele, mis võivad olla valusad tunnistada. Lausu näiteks: „Kui tunnete, et vajate tuge enda tasakaalus hoidmiseks, on ka selleks võimalusi.“
- Viita olemasolevatele enesehoiu ressursidele (nõustamised, tugigrupid, psühholoogid, eneseabi võtted). Lausu näiteks: „On olemas tasuta perenõustamine, kus saab ka iseenda tunnetest rääkida.“

Nii tunneb pere, et nende vaimne tervis on tähtis, mitte isiklik nõrkus ja neid ei kasutata ära ainult lapse teenindamiseks, vaid toetatakse ka inimestena.

5.5. ANNA PERELE VÕIMALUS ISE PRIORITEEDID SEADA

Praktikas tähendab see, et:

- Jaga infot ja vajadusel tõsta vanema teadlikkust tema ja lapse suhete olulisusest. Lausu näiteks: „Lapse turvatunde tekkimine on tugevalt seotud sellega, kuidas te temaga suhtlete – ja teie lähenemine toetab teda väga.“
- Julgusta vanemat, kui ta kahtleb enda tegevuses või oskustes lapsega toimetada. Lausu näiteks: „Isegi väikesed asjad, nagu koos lugemine või rahulik kuulamine, aitavad last rohkem kui te arvatagi oskate.“

Nii tunneb pere, et nad on lapse elus tähtsal kohal, neil on mõju, mis ei sõltu formaalsest abist ning nad saavad kindlust, et on õigel teel, isegi kui seal püsimine on raske.

5.6. SA EI VÕTA PERELT ÄRA VASTUTUST, VAID TOETAD AUTONOOMSUST JA VALIKUVABADUST

Praktikas tähendab see, et:

- Jäta perele otsustus- ja valikuvabadus selle üle, milline lahendus on nende eluolukorras asjakohane. Nii toetad autonoomsust ja säilitad inimestele enesemääramisõiguse. Lausu näiteks: „Kui mõelda teie pere hetkeolukorrale – mis aitaks teil tunda end tugevamana?”
- Sinul on võimalus pakkuda valikuid, mitte käske. Lausu näiteks: „Soovi korral saame uurida paari võimalust. Teil on õigus öelda, mis sobib ja mis mitte.”

Nii tunneb pere, et nad ei ole „juhtum“, vaid osalevad oma eluolukorra lahendamisel, ning neil on kontroll ja valikuvõimalus, mis tähendab, et neid usaldatakse.

6. KOKKUVÕTE

Kokkuvõtvalt, tegutsedes puudega lapse ja tema pere heaks põhimõtetel, mis toetavad inimväärikust, turvatunnet ja koostööd, kätkeb see endas suurt mõju ja kasu nii puudega lapsele ja tema vanematele kui ka ametnikule/lastekaitsetöötajale ja sotsiaalkaitse-süsteemile laiemaltki. Kui ametnik käitub lugupidavalt, kuulavalt ja koostöiselt, siis pere tahab teha koostööd. Kui pere usaldab ametnikku, saab ametnik teha oma tööd paremini ja tulemuslikumalt. Kui mõlemad pooled tunnevad, et neid väärtustatakse, siis sünnib päris muutus, mitte pelgalt „järjekordne juhtum“.

6.1. MÕJU JA KASU LAPSELE JA PERELE

- **Pere kogeb usaldust, mitte hirmu või hinnanguid.**
Vanemad julgevad abi küsida ja teha koostööd, mitte varjata probleeme.
- **Pere tunnetab oma väärtust ja suutlikkust.**
Kasvab vanema enesekindlus, mis toetab ka lapse arengut.
- **Laps tajub, et tema hääl loeb ja ta on oluline.**
Paraneb lapse turvatunne ja koostöövalmidus.
- **Pere leiab üles enda olemasolevad tugevused**
Väheneb sõltuvus välisest abist, suurenevad toimetulekuoskused.
- **Vanem saab pöörata tähelepanu ka iseenda heaolule ja enesehoiule**
Väheneb läbipõlemise oht ja paraneb püsiv suutlikkus last toetada.

6.2. MÕJU JA KASU AMETNIKULE/LASTEKAITSETÖÖTAJALE/ SOTSIAALSÜSTEEMILE

- **Väheneb vastasseis ja kaebused abivajavate perede poolt – kasvab koostöö.**
Pere ei näe ametnikku kontrollijana, vaid partnerina.
- **Tegelik olukord saab selgeks kiiremini ja usaldusväärsemalt.**
Pere räägib rohkem ja ausamalt, kui tunneb, et teda kuulatakse ja ei hinnata.
- **Ametnik saab paremini sihtida teenuseid ja toetust.**
Ei kulutata aega ega vahendeid sobimatutele lahendustele.
- **Töö muutub tähenduslikumaks ja vähem kurnavaks.**
Kui muutused toimuvad, kogeb ametnik, et tema töö aitab inimesi päriselt.
- **Kasvab usaldus sotsiaalsüsteemi vastu.**
Kui pered räägivad oma headest kogemustest, on teisedki valmis avatumalt abi otsima.

6.3. KASUTATUD ALLIKAD

- Lastekaitseseadus
- Sotsiaalhoolekande seadus
- Eesti Vabariigi põhiseadus
- Sotsiaalvaldkonna töötaja eetikakoodeks
- ÜRO lapse õiguste konventsioon
- ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon
- Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon
- ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon
- Euroopa Liidu põhiõiguste harta
- Euroopa Nõukogu lapse õiguste strateegia 2022–2027
- Euroopa Nõukogu soovituselaste osaluse kohta (CM/Rec(2012)2)
- ÜRO lapse õiguste komitee üldkommentaari nr 9 (puudega laste õigused)
- ÜRO lapse õiguste komitee üldkommentaari nr 12 (lapse arvamuse austamine)

Mõlema silma pimedus

1. TERVISESEISUNDIST ÜLDISEMALT

Nägemispuude põhjuseks võivad olla kaasasündinud seisundid, haigused või traumad. Nägemispuudega inimesteks loetakse vaegnägijaid ja pimedaid, sh need, kellel esineb mõlema silma pimedus. Levinud eksiarvamuse kohaselt ei näe pime inimene üldse midagi. Tegelikult on paljudel pimedatel inimestel säilinud osaline valgus- ja varjutaju; nad võivad tajuda ümbrust uduselt, näha „tunnelvaates“ või kogeda keskse nägemisvälja puudumist. Kuna silmahaigusi on erinevaid, varieerub ka nägemiskaotuse iseloom suurel määral. Eestis on nägemispuude tekke peamisteks põhjusteks haiguste tüsistused, kõrge lühinägevus, nägemisnärvi atrofia, glaukoom ehk rohekae, kaasasündinud kahjustused ja diabeet.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni käsitlese järgi jagatakse nägemispuudega inimesed viide rühma:

I rühm	On võimeline lugema peaaegu normaalselt kauguselt ja tavapärase kiirusega, kuid vajab seejuures abivahendeid.
II rühm	On võimeline lugema ja kirjutama abivahenditega, kuid teeb seda nägijast aeglasemalt. Üldine nägemine pole piisav, kuid seda saab kasutada.
III rühm	Lugemine ja kirjutamine on vähetulemuslikud. See õnnestub ainult eriti tugeva motivatsiooni korral ning abivahendite toel. See rühm inimesi kasutab täpselt ühte punkti suunatud nägemist.
IV rühm	Praktiliselt pime. Tavaliselt ei saa ta oma nägemist kasutada, kuna eristab ainult valgust.
V rühm	Täiesti pime, kes ei erista ka valgust.

Pimedateks loetakse inimesi kolmandast kuni viienda rühmani, kelle nägemisteravus on alla 0,1 või vaateväli kitsam kui 20 kraadi. Euroopas on nägemiskaotus keskmiselt igal kolmekümnnendal inimesel ning maailmas tervikuna on iga 250. inimene pime. **Eestis oli 2025. aasta seisuga registreeritud 252 nägemispuudega last, eraldi pimedate laste statistika Eestis puudub.**

Sageli kajastatakse nägemispuudega lapsi liitpuudega laste hulgas, kuna nägemispuue võib esineda samaaegselt teiste puuetega. Tänapäeva meditsiin võimaldab osa pimedana sündinud lapsi operatsioonide abil aidata sellisel määral, et laps vajab hilisemas elus vaid prille või minimaalset tuge, mis puutub nägemisse.

2. SUHTLEMINE PIMEDA LAPSEGA

Nagu ka kõikide teiste laste puhul, tuleb tagada lapse heaolu ja turvalisus ning selgitada, mis on sinu kui spetsialisti roll tema toetamisel ([vt ka ametniku sekkumise eetika peatükki](#)).

Toome allpool ära suhtlemissoovitused, mis tulenevad pimedale inimesele spetsiifikast ja aitavad luua pimedale lapsega turvalist ja toetavat koostöösuhet.

- Pimedale lapse kõnetamisel puuduta tema käsivart/õlavart või pöördu tema poole nimeliselt ja tutvusta ennast nimeliselt ja ameti poolest.
- Kui laps tuleb sinuga kohtuma, siis **kirjelda talle ümbritsevat ja ka iseennast** (millised on su juuksed, silmade värv, milliseid riideid kannad).
- Vesteldes **ei ole vaja valjusti rääkida**.
- Lapsega suhtlemisel **pöördu tema poole, mitte tema vanema vm saatja poole**. Kui kirjeldad lapsele millegi asukohta, siis kasuta sõnu „vasakul“, „paremal“, „üleval“, „all“ vmt. Kirjeldamisel võib kasutada nt kellaosuteid, kui laps tunneb kella („kella kuue suunas“, „kolme peal“ jne). Ära karda kasutada sõnu „nägema“, „vaatama“, „ilus“ jne.
- Juhul kui pead lapsega koos liikuma, siis küsi, kas ta vajab abi. **Pimedale inimesele liikumisel kasutatakse saatjavõtet** – pime inimene võtab kinni sinu küünarvarrest, sina liigud ees, et kirjeldada ümbrust ja teelolevaid takistusi.
- Pimedale lapse juurest **lahkudes ütle talle, et sa lähed eemale**, siis laps teab, et sa eemaldusid ja ta ei räägi tühja kohaga.

Pimedate laste jaoks vajaliku info kättesaadavuse tagamiseks on digi- ja audiomaterjalid (näiteks pimedate raamatukogu, kust on võimalik laenutada heli- ja punktkirjas raamatuid, puuteraamatuid ja e-raamatuid ning kirjeldustõlkega filme).

Kirjeldustõlge vahendab pimedale inimesele visuaalsust selleks õppinud kirjeldustõlgi abil. Nägemispuudega inimesele luuakse ettekujutus nähtavast objektist või tegevusest sõnalise kirjelduse kaudu. Kirjeldustõlget saab kasutada näiteks etenduste tõlkimisel, et kirjeldada pimedale laval toimuvat, või muuseumi eksponaatide kirjeldamisel, ka fotode jm visuaalsete võimaluste (videote) puhul. Ligipääsetavust suurendavad kirjeldustõlke abil tehtud liikumisjuhised, mis kirjeldavad pimedale inimesele liikumisteede tema soovitud sihtpunkti.



3. KUIDAS TOETADA PIMEDAT LAST JA TEMA PERET?

Varajase algusega ja pöördumatu raske nägemiskahjustus võib väikelastel aeglustada mootorset, kõnelist, emotsionaalset, sotsiaalset ja kognitiivset arengut. Kooliealistel nägemispuudega lastel võivad samuti olla madalamad õpitulemused, mistõttu on oluline, et lapsele ja perele pakutakse abi võimalikult varajases eas.

Abi ja toe pakkumisel pea meeles:

- Lapsevanem tunneb oma last kõige paremini ja tal on lapse kohta olulist teavet nii tema tervisliku seisundi, igapäevaelu oskuste kui ka harjumuste osas. Kuid ka lapsevanem võib olla teadmatutes, kui tal puudub varasem kokkupuude pimedaga inimesega ja temagi võib vajada tuge, mis seisneb spetsiifiliste teadmiste ja oskuste saamises näiteks rehabilitatsioonispetsialistide poolt.
- Enne kui pakud lahendusi, küsi alati, millised on lapsevanemate ja lapse enda soovid ja vajadused.
- Toe pakkumist võib raskendada lapsevanema vähene teadlikkus pimedaga lapse kasvatamise võimalustest – leidub vanemaid, kellel on keeruline uskuda, et ka pime inimene suudab iseseisvalt toime tulla. See võib viia selleni, et lapsel kujuneb välja nn õpitud abitus. Seetõttu on oluline vanemat julgustada, aidata tal näha ja usaldada lapse võimekust ning toetada teadlikult viimase iseseisvust.
- Psühholoogiline abi ja toetus võib perele vajalik olla erinevatel ajahetkedel – terviseseisundi tekkimisel, diagnoosi saamisel, ealistel ja arengulistel üleminekutel (nt lasteaeda, kooli). Terviseseisundi tekkimisel ja diagnoosimisel võivad vanemaid tabada šokiseisund, lein, süütunne ja ärevus tuleviku ees. Eriti väikelapse puhul on vanemate psühholoogiline toetamine oluline, et vanema ärevus ja hirmud ei kanduks üle lapsele. Lasteaeda või kooli minnes tuleb toetada lapse sotsiaalseid oskusi, enesekindlust ja iseseisvust ning peret tervikuna, et ootused haridustee osas oleksid realistlikud.

Lapse arendamisel on oluline:

- **Pime laps vajab erilist arengukeskkonda**, kuna tal puudub võimalus visuaalsel teel maailmast infot saada. Pime laps peab saama kõike kogeda, katsuda, maitsta, nuusutada, samuti liikuda erinevatel tasapindadel.
- Tasakaalu arendamine, ruumitaju õpetamine, kajakuulmise arendamine, kõigi teiste meelte arendamine, ümbruskonna kirjeldamine. Eesmärk on **maailmast tervikliku pildi saamine**.
- **Punktkirjaoskuse omandamine, tänu millele areneb õigekiri ja avaneb võimalus kirjalikuks eneseväljendamiseks.** Esimene kirjaoskus peab olema punktkiri. Seejärel minnakse üle heliväljendusele.
- **Sõrmetundlikkuse arendamine punktkirja õppimiseks.**

- **Füüsiline liikumine** – ujumine, selja-, kõhu- ja jalalihaste treenimine, et laps ei jääks küüru ega kehaliselt nõrgaks. Võimaluste uurimiseks tasub kontakteeruda Eesti Pimedate Liiduga või rehabilitatsioonispetsialistidega. Erivajadustega noortel on võimalik tiiptasemel tegeleda paraspoordiga Eesti Paralümpiakomitee kaudu.
- **Korraharjumuse kujundamine.** Selge ja struktureeritud keskkond laseb pimedal inimesel tunda ennast turvalisemalt ja rahulikumana, korraharjumus suurendab iseseisvust ja toetab enesekindlust.

3.1. TEENUSED

Pime laps ja tema pere võivad vajada mitmesuguseid teenuseid, mis aitavad lapsel iseseisvuda ja võimaldavad vanematel tööl käia.

- Kohaliku omavalitsuse poolt pakutavateks teenusteks on näiteks **isiklik abistaja või tugisik, kes aitab lapsel turvaliselt liikuda ja toimetada lasteaias, koolis, huviringis jne.**
- Rehabilitatsiooniteenused. Rehabilitatsiooniteenuste eesmärk on **vähendada nägemispuude mõju lapse arengule, sh on oluline ka pere nõustamine.** Rehabilitatsiooniteenuste käigus õpetatakse last kasutama abivahendeid, näiteks eripedagoogi ülesanne on õpetada ekraanilugemisprogrammide ja valge kepi kasutamist, ruumis orienteerumist ja liikumist, anda punktkirjaoskus ja arendada toimetulekuoskuseid (söömine, riietumine, isiklik hügieen).
- Heaks tavaks on kohaliku omavalitsuse poolt **koolivaheaja sisustamine, et laps oleks hoitud ja vanemad saaksid käia tööl.** Näiteks Eesti Pimedate Liit ja kohalikud nägemispuudega inimeste organisatsioonid on korraldanud nägemispuudega lastele, noortele ja peredele mõeldud erinevaid üritusi, mille kohta saab informatsiooni küsida otse neilt.

3.2. ABIVAHENDID

Abivahendid on olulised, et lapsel oleks võimalik varakult õppida toimetulekuoskusi ja kasvatada oma iseseisvust. Soovitusi abivahendite hankimiseks annavad rehabilitatsioonispetsialistid, kes õpetavad last ka abivahendit kasutama. **Abivahendi vajaduse tuvastab silmaarst, optometrist või perearst, kes väljastab lapsele abivahendi töendi, mille alusel on võimalik saada paljusid abivahendeid soodustingimustel.** Abivahendeid müüvad ja üürivad abivahendite ettevõtted, kes oskavad lapsele ja perele soovitada erinevaid abivahendeid ning leida nende seast sobivaima.



Abivahendid saab jagada erinevateks kategooriateks (mõned näited):

Ajatajuga seotud abivahendid	Kõnelevad, taktilised ja suurte numbritega kellad.
Liikumise ja orienteerumisega seotud abivahendid	Valge kepp, heliga takistusteataja, tumedad filterklaasid (suure nägemislangusega kaasneb silmade valguskartus), kaitseprillid, mis kaitsevad silmi tolmu ja mehaanilise kukkumise eest.
Mänguasjad (ei ole abivahendite nimekirjas)	Kellukestega pallid, peenmotoorika arendamiseks lauamängud, Lego klotsid, taktilised pusled.
Igapäevase toimetulekuga seotud abivahendid nagu riietumine, söögi tegemine jne	Ahjukinnas, kõnelev toidukaal, kõnelev värvimääraja, kõnelev toidutermomeeter.
Suhtlemisega seotud abivahendid	Kõnelevad mobiil- ja lauatelefonid.

4. ÕPPE KOHANDAMISEGA SEOTUD BAASVAJADUSED

Igal lapsel on seadusest tulenev õigus võimetekohasele ja toetatud õppele ning olenemata puude või diagnoosi olemasolust või puudumisest peab õppe- ja kasvatustegevus olema alati kohandatud õppija vajaduste ja võimete järgi. Lapse õigused ning hariduse korraldamise põhimõtted on puude/diagnoosi olemasolust sõltumata samad.

4.1. ALUSHARIDUS

Lasteaad lähtub õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest, mille kohaselt osaleb laps õppe- ja kasvatustegevuses suurema osa ajast koos kõigi teiste lastega ja oma õpetaja juhendamisel. Igale lapsele tagatakse õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös võimetekohane õpe ja vajalik tugi. Vajaduse korral koostab rühmaõpetaja koostöös abiõpetaja, tugispetsialisti ja vanemaga lapsele arenduskava.

Lapse individuaalsetest võimetest ja vajadustest lähtuvalt osutatakse lasteaias lapsele üldist, tõhustatud või erituge. Toe liik väljendub eelkõige lapse vajadustele sobiva kollektiivi suuruses, tugispetsialisti teenuse mahu ning spetsiifiliste kohanduste ulatuses õppe- ja kasvatusprotsessis (sh mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid). Haridusliku erivajadusega laps lasteaias võib vajada kas väiksemat kollektiivi või individuaalset lisatuge rühmas.

Kui üldjuhul teeb lapsele sobiva suurusega rühma ja individuaalse lisatoe tagamiseks soovitusel kooliväline nõustamismeeskond, siis soovitus ei ole nõutav laste puhul, kellel on diagnoositud mõni igal ööpäeval või ööpäev läbi kõrvalabi vajadust põhjustav tervise seisund või tuvastatud puude raskusaste ning lasteaiale on edastatud sellekohased objektiivsed andmed (nt puudeotsus või tugiteenuste vajadust kirjeldav arsti väljastatud tervise seisundi hinnang). Sellisel juhul tuleb õppe- ja kasvatustegevuse kohandamisel järgida eriarsti poolt antud tervise seisundi hinnangut (nt epikriis), rehabilitatsiooniplaani või puude raskusastme tuvastamise otsust.

4.2. PÕHI- JA GÜMNAASIUMIHARIDUS

Lähtuvalt kaasava hariduse põhimõtetest on igal lapsel õigus õppida kodukohalähedases koolis, elukohajärgsel koolil ei ole õiguslikku alust õpet mitte pakkuda. **Eraldi pimedatele orienteeritud koolid Eestis on riiklik erikool Tartu Tähtvere Riigikool ja munitsipaalkool Tallinna Heleni Kool (viimases õpetatakse ka kuulmis-, kõne- ja liitpuudega lapsi).**

Tartu Tähtvere Riigikooli pimedate osakonnas (endise nimega Tartu Emajõe Koolis) on võimalik omandada ka keskharidus. Tavaõppe edukuse tagab koostöö kooli, pere ja õpilase vahel, nägemispuudega õpilase enda ja ka pedagoogide ning kaasõpilaste suhtumine puudesse, õpilase sotsiaalsed oskused, õppeedukus ja töövõime ning võimalikult varane sekkumine nägemispuudega lapse arengusse.

Pimeda õpilase puhul rakendatakse õpilasele erituge; see tähendab, et tal on õigus puudespetsiifilisele õppekorraldusele, -keskkonnale, -metoodikale ja -vahenditele. Samuti peab olema tagatud pidev tugispetsialistide toetus ning vajadusel osajaga õpe individuaalselt või rühmas või pidev tugi klassis või õpe eriklassis.

Tavakoolis õppiva nägemispuudega õpilase õpetamisel on olulised:

- 1. Abivahendid ja nende kasutamise õpetus.**
- 2. Õpetajate erivajadustealase nõustamise võimalus** koolis.
- 3. Kohandatud õppematerjalide** olemasolu.
- 4. Individuaalne õppekava.**
- 5. Osa- või täiskoormusega töötav nägemispuudega õpilase abistaja.**
- 6. Keskkonna kohandus** – sobiv valgustus; suurem tööpind; sobiv istumiskoht klassis; võimalus tahvli juurde vaatama minna; individuaaltunnid igapäevatoimingute, suhtlemis-, orienteerumis- ja liikumisoskuste õppimiseks.
- 7. Õpetajad peavad teadma, kuidas mõjutab last nägemispuue ja mõistma nägemispuudest tulenevaid erivajadusi** – millisel määral saab õpilane kasutada nägemist lähitöös, millist valgustust ja milliseid abivahendeid ta vajab, kuidas ta saab liikuda tuttavas ja ka võõras ümbruses. Vastuseid aitab leida koostöö lapsevanemate ja rehabilitatsiooniasutuse spetsialistidega ning lapse jälgimine ja küsitlemine.

Pimedad õpilased kasutavad erinevaid abivahendeid: punktkirjamasin, valge kepp, diktofon, kõnega kalkulaator, joonestusalus, reljeefse märgistusega mõõtmisvahendid jne. Vanemad õpilased kasutavad ka sülearvutit, mis on varustatud ekraanilugemisprogrammi ja punktkirjakuvariga.

4.3. NÄIDE PRAKTIKAST

Heaks näiteks ja eeskujuks nägemispuudega laste õpetamisel ja arendamisel on olnud Vanalinna Hariduskolleeegium. Tegemist on tavakooliga, kus pimedale lapsele on tagatud eripedagoog, kes korraldab pimedale lapsele vajalikud kohandatud õppematerjalid.

5. LISAINFO

- **Eesti Pimedate Liit ja liikmesorganisatsioonid:** pimedateliit.ee
- **Eesti Pimekurtide Tugiliit:** www.pimekurdid.ee/
- **Pimedate raamatukogu:** www.rara.ee/pimedate-raamatukogu
- **Eesti Nägemispuuetega laste vanemate Liit:** www.facebook.com/ENLVL/
- **Paralümpiakomitee** (tegeleb erivajadustega inimeste tippspordi edendamise): www.paralympic.ee
- **Jooksusilmad** (kogunemiskoht nägemispuudega jooksjatele ja nende saatjatele): <https://www.facebook.com/groups/1276488659385287/>
- **Infopunkt omastehoolduse teemadel, sh hooldusvajadusega laste toetamine** (teenused, abivahendid, haridus, jõustavad kogemuslood) www.omastehooldusest.ee

5.1. KASUTATUD ALLIKAD

- **Eesti Pimedate Liit:** www.pimedateliit.ee
- **Teatmik õpetajatele. Märka ja toeta last:** www.hm.ee/sites/default/files/documents/2022-07/teatmik_opetajatele.pdf
- **Nägemispuudega inimeste rehabilitatsiooniteenused:** https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/N%C3%A4gemispuudega-inimeste-rehabilitatsiooniteenused-jaosmaterjal_veebi.pdf
- **Puudega inimeste statistika:** <https://epikoda.ee/spetsialistile/statistika>

Intellektipuue

1. TERVISESEISUNDIST ÜLDISEMALT

Intellektipuue ei ole haigus, vaid **püsiv seisund, mis avaldub tavaliselt lapseas**. Intellektipuudega lastel on eakaaslastest madalam võime igapäevaeluga iseseisvalt toime tulla. Neil võib olla **raskusi suhtlemise, enese eest hoolitsemise, kõne, mootorika ja sotsiaalsete olukordadega kohanemisel**. Arengulisi kõrvalekaldeid võib märgata juba imiku- ja väikelapseas või ilmnevad need hiljem, näiteks koolieelsetel aastatel. Intellektipuude raskusastet hinnatakse intelligentsustestidega (IQ).

Intellektipuude raskusastmed ja nende iseloomustus:

Intellekti- puue	Arengutase (IQ)	Iseloomustus
Kerge	Arengutase võrreldav 7-12 aastase lapsega	Võib vajada lisaselgitusi, et saada aru abstraktsetest mõistetest (nt aeg, distants, mõtete planeerimine). Tavaliselt suudab laps siiski suhelda ja väljendada oma vajadusi ja tundeid.
Mõõdukas	Arengutase võrreldav 4-7 aastase lapsega	Vajab toetust igapäevaelu tegevustes, samuti lisaselgitusi, et saada aru abstraktsetest mõistetest. Võib esineda raskusi kõne mõistmisel ja eneseväljenduses. Sageli kaasnevad ka terviseprobleemid ning raskused liikumisel, võib vajada kõrvalabi siirdumise planeerimisel.
Raske	Arengutase võrreldav 2-4 aastase lapsega	Vajab igapäevaelus olulisel määral kõrvalabi ja aega uutes olukordades kohanemiseks. Suhtlus on piiratud ja raskendatud. Sageli kaasnevad terviseprobleemid ja liikumisraskused, vajab siirdumisel kõrvalabi.
Sügav	Arengutase võrreldav 0-2 aastase lapsega	Suhtlemisoskus on väga piiratud ning peamiselt mitteverbaalne. Ei erista ennast teistest, kuna minateadlikkus ei ole välja kujunenud. Kogeb maailma meelte ja liikumise kaudu. Asju, mida ta ei näe, ei kuule, ei tunne ega maitse, pole tema jaoks sel hetkel olemas. Vajab hooldust ja kõrvalabi ööpäev läbi, ent võib juhendamisel õppida lihtsaid praktilisi oskusi.

Intellektipuudega lapsel on **keeruline üldistada, samuti aru saada abstraktsetest asjadest** (nt raha või asjad, mida ta ei näe). Intellektipuudega lapsel on keeruline planeerida ja tajuda aja kulgu, tal on raskem õppida, kohaneda uutes olukordades, mõista sotsiaalseid ja ühiskondlikke reegleid. **Intellektipuudega lapsed ei suuda luua eelarvamusi, mistõttu on nad väga avatud ja siirad.**

Intellektipuude tekkimise põhjuseid võib olla palju, näiteks sünnieelne kahjustus, sünnitrauma, ajukahjustus, halvad keskkonnatingimused esimesel eluaastal, kromosoomihaigused, geenimutatsioonid, aju ehituslikud muutused, enneaegsusest tingitud tüsistused. Maailmas on intellektipuudega inimesi u 2–3% kogu elanikkonnast.

Intellektipuude diagnoosimisel on väga oluline tunda peres esinevaid haigusi ja probleeme. Teave perekonnas ja suguvõsas avaldunud vaimsete, neuroloogiliste või teiste probleemide kohta võib aidata leida intellektipuude põhjust. **Lapsevanematele on oluline kinnitada, et diagnoosi olemasolu ei tohiks karta, sest ilma diagnoosita võivad hilineda ka arendavad tegevused.** Esimestel eluaastatel on lapse aju plastilisem ja seega on arendustegevuse tulemused paremad. Siiski tuleb arvestada, et palju on ka intellektipuude põhjustest ja raskusest. Spetsialist saab lapsevanemaid suunata meditsiinilist abi otsima, juhul kui lapse areng ei ole tavapärane. Spetsialist, kellel pole meditsiinilaseid eriteadmisi, ei saa lapsevanemale rääkida intellektipuude kahtlusest, kuid ta saab viidata sellele, et lapse areng ei kulge tavapäraselt ning konsulteerida võiks arstiga.

2. SUHTLEMINE INTELLEKTIPUUDEGA LAPSEGA

Nagu kõikide laste puhul, tuleb tagada lapse heaolu ja turvalisus ning selgitada vastavalt lapse arengutasemele lihtsas keeles, mis on sinu kui spetsialisti roll tema toetamisel ([vt ka ametniku sekkumise eetika peatükki](#)). Intellektipuudega lapse meeled ja tajud on ülitundlikud, nad on suhtlemisel sõbralikud, südamlikud ja avatud, neil on keeruline eristada olulist ebaolulisest. Intellektipuudega lapsed kohanevad raskemini ja selle tõttu on ka keskkonnamuutused neile raskemini talutavad ja võtavad oluliselt kauem aega. Kriisiolukorras sõltub toimetulek keskkonnast – nii füüsilisest kui suhtumuslikust (kohalolevate inimeste toetusest ning mõistmisest).



Intellektipuude spetsiifikast tulenevad suhtlemissoovitused:

- Kohtle last eakohaselt ja austavalt.
- Koosta alati lühikesed ja lihtsa sõnumiga laused. Võta suhtlemiseks tavapärasest rohkem aega.
- Kui laps kasutab suhtlemiseks alternatiivkommunikatsioonivahendeid, siis kasuta samu vahendeid, samu pilte, samu väljendeid. Küsi nõu ja abi lapsevanemalt või lapsega vahetult tegelevalt spetsialistilt. Juhul kui laps ei suhtle verbaalselt ega kasuta alternatiivkommunikatsioonivahendeid, soovita vanemal neid võimalusi uurida (rehabilitatsioonispetsialistidelt, abivahendi ettevõtetest, samuti suhelda teiste peredega, kes kasutavad näiteks kommunikaatorit).
- Räägi lapsega otse, võid julgelt kasutada sina-vormi.
- Enne puudutamist veendu, kas see on vastuvõetav.
- Kasuta lihtsaid arusaadavaid sõnu.
- Korduvate küsimuste korral vasta alati samamoodi, see pakub turvalisust.
- Kasuta asjade seletamiseks näiteid, mida laps tunneb oma igapäevaelust.
- Ära kasuta metafoore või abstraktseid väljendeid. Ära tee kahemõttelisi nalju. Ole konkreetne. Ära kasuta umbmääraseid sõnu – kohe, varsti, natukese aja pärast jne.
- Ära kasuta võõrkeelseid sõnu, kui nad pole nii hästi tuntud kui näiteks „okei“.
- Välti lühendite kasutamist.
- Kuna protsentide ja suurte numbrite mõistmine on raske, kasuta sõnu „vähe“ ja „palju“, et oma mõtet selgitada.
- Anna suhtluse alguses väga selge ja lihtne ülevaade eesootavast ja pikema kontakti korral tee seda päeva jooksul uuesti.
- Kokkuleppeid sõlmides ja reegleid tutvustades veendu, et laps neid mõistaks, võimalusel korda. Palu tal kuuldu üle korrata. Juhendamisel eelista suulise selgitamise asemel pigem näitlikustamist või koos läbi tegemist.
- Arvesta, et vastamata jätmine või aeglane reageerimine ei tähenda ebaviisakust.
- Arvesta, et iga tegevuse läbiviimine, nt asjaajamine, ekskursioon või lihtne poeskäik võtab rohkem aega. Võimalusel kohanda tegevust, vähendades tavapärast infomahtu või jagades pikem tegevus eraldi aegadele.
- Välti plaanide äkilist ja spontaanset muutmist – intellektipuudega laps tunneb end kindlamalt rutiinsetes olukordades, kui ta teab, mis järgmisena toimuma hakkab.
- Kasuta ka kirjas lihtsat keelt.
- Intellektipuudega lapsel on alati lihtsam sinust aru saada, kui teil on vahetu kontakt, ta näeb, kuuleb sind ja ta saab kasutada oma meeli.

3. KUIDAS TOETADA INTELLEKTIPUUDEGA LAST JA TEMA PERET?

Pere toetamise keskseks märksõnaks on varajane sekkumine, sest tänu sihipärasele arengu toetamisele õpib ja omandab intellektipuudega laps uusi oskusi. Uute oskuste omandamine võtab küll eakohase arenguga lastest kauem aega, kuid väikeste sammude haaval on siingi võimalik tulemusi saavutada. Intellektipuue nõuab **pikaajalist, perekesket ja koordineeritud tuge. Varajane sekkumine, ennustatav rutiin ja visuaalselt toetatud õpe aitavad lapsel omandada maksimaalse iseseisvuse. Oluline on mõista lapsevanemate väsimust, meeleheidet ning hirmu tundmatu ja ebaturvalise tuleviku ees.**

Praktikas tähendab see:

- **Ole mõistev ja hinnangutevaba.** Esmase kontakti korral tutvu kogu informatsiooniga, mis on sulle kättesaadav.
- Vanemad ei pruugi tegutsemiseks kohe valmis olla ja sellest tulenevalt tuleb **lapse vajadustest lähtuvalt leida parim viis, kuidas abi jõuaks lapseni võimalikult kiiresti.**
- Spetsialisti roll on olla teejuht – **pakkuda selget teavet, koordineerida teenuseid ning tunnustada pere tugevusi igas arenguetapis.** Lapse hindamise protsess on sageli pikk ja vajab erinevaid spetsialiste. Lapse elukoht ja **kohaliku omavalitsuse abi on kõige olulisema kaaluga, sest sellest sõltub, kui kiiresti laps sobivale teenusele saab, et lapse areng oleks maksimaalselt toetatud.**
- Kui perel on **vanavanemad**, siis **nende kaasamine** ja olukorra aus kirjeldamine toob juurde ressursi. Kui vanavanemad jäetakse infosulgu, süvenevad nende hirmud ja eelarvamused veelgi.
- **Vanemate tavapärase töö- ja pereelu säilitamine on baas pere toimetulekule.**
- **Pere teised lapsed vajavad jätkuvalt samamoodi tähelepanu**, nagu nad said enne erivajadusega lapse sündi. Lapsevanemad peavad saama selleks aega, et laps tunneks, et teda kuulatakse, märgatakse ja talle pühendatakse aega isa või emaga (abi võib olla näiteks lapsehoiu- või tugiisikuteenusest).
- **Kogukonna harimine.** Teadlikkus erivajadusega lapsest kogukonnas ja tema vajadustest väldib mõistmatust ja ennetab hirme, mis tekivad, nähes teistsugust käitumist.
- Intellektipuudega lapse sünd toob kaasa palju erinevaid uuringuid, teraapiaid ja teenuseid. Nende planeerimisel **tuleb arvestada lapsevanemate ja lapse võimekusega, sest väsinud vanem ei pruugi jaksata olla osavõtlik ja väsinud laps ei ole arendustegevustele vastuvõtlik.** Vanemate aega ja jaksu aitab hoida kokku transpordi korraldamine, vajadusel teenustel käimine tugiisikuga. Võtmeks on meeskonnatöö ja juhtumikorraldus lapse ja pere hoidmiseks protsessis.

- **Spetsialistina tuleb sul aktiivselt tutvustada olemasolevaid võimalusi, teraapiaid, teenuseid** nagu näiteks lapsehoiu- ja tugiisikuteenuse võimalused, rehabilitatsiooniteenused, huvihariduse võimalused piirkonnas (sh uurida, milline on võimekus pakkuda intellektipuudega lapsele huvitegevust, sest huviharidus pole kogu Eestis ühtlaselt kättesaadav; näiteks uurida, mida pakub Eriolümpia Eesti Ühendus või Paralümpiakomitee). Lisaks tutvustamisele anna ülevaade võimalustest kaasa paber kandjal, aita lapsevanemal pöörduda, kuhu vaja, aita täita taotlust, kui ta seda vajab.
- Järjepidevus ja planeeritud kohtumised aitavad kaasa, et lapsevanemal oleks võimalik küsida, sisse viia muudatusi ja saada muutuvast olukorras tuge. **On oluline, et oleks üks kindel inimene, kes hoiab järjepidevust, juhib protsessi.**

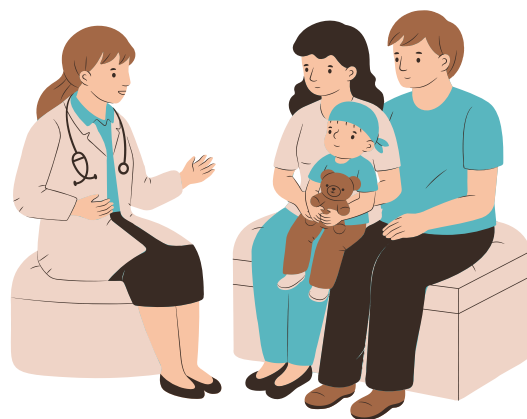
3.1. ABIKS TERVISHOIUTÖÖTAJALE

Iga laps areneb omas tempos, kuid arenguetappide tundmine aitab märgata kõrvalekaldeid.

Praktikas tähendab see:

- Soovita vanematel **pidada arengupäevikut**: kirja panna sündimandmed ja esimesed tähtsad hetked (pilgukontakt, naeratus, peahoid, istumine, esimesed sammud jm). Esimesed kaks eluaastat on eriti intensiivsed – hiljem on hea nendele märkmetele tugineda, et hinnata lapse edasiminekut. Tööriistaks [Lapse tervise päevik](#).
- Arengut jälgivad perearst ja pereõde regulaarsetel visiitidel. Kohtumistel küsi sisulisi küsimusi: "Kuidas laps sööb?", "Kuidas ta magab?". Vajadusel täpsusta küsimust.
- Uuri, kuidas vanem end tunneb. Soe ja huvitatud suhtlus loob usalduse ning julgustab vanemat jagama oma kahtlusi ja hirme. **Välgi lohutust fraasiga „küll tuleb“** – kui mure püsib, suuna laps õigel ajal täiendavale konsultatsioonile.
- **Perearstina suuna arenguhäire kahtluse korral laps õigel ajal edasi eriarsti juurde. Eriarstina koordineeri uuringud ühtse plaanina, et pere ei peaks ise eri spetsialistide vahel laveerima.**

Intellektipuude diagnoosimine on põhjalik protsess, mis võtab tavaliselt aega ja hõlmab mitme eriala spetsialiste – neuroloog, geneetik, psühhiaater, logopeed, eripedagoog ja kliiniline psühholoog.



4. ÕPPE KOHANDAMISEGA SEOTUD BAASVAJADUSED

4.1. ALUSHARIDUS

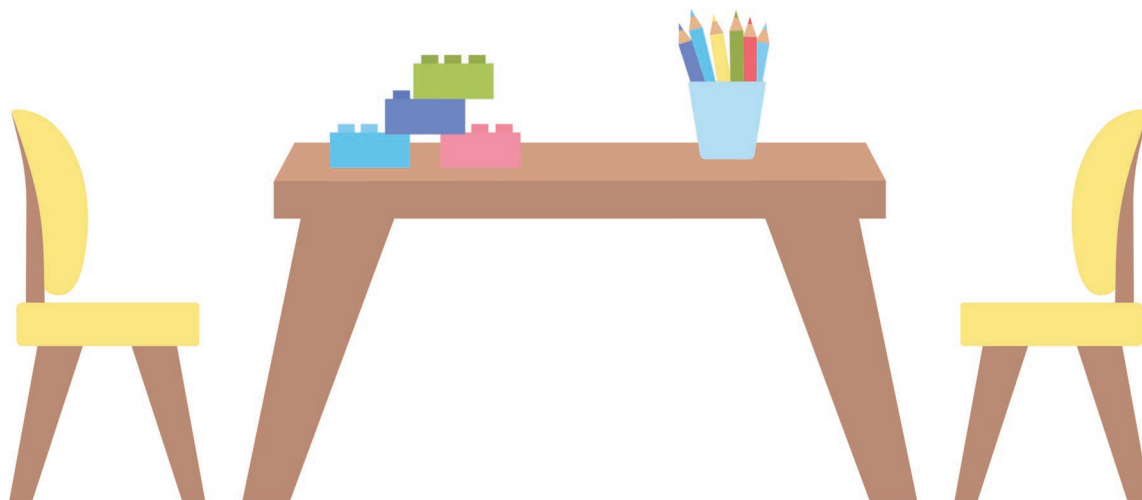
Intellektipuudega lapse haridustee kujundamise põhimõteteks on varajane sekkumine ja individuaalse arenguga arvestamine. Üldised põhimõtted kehtivad erinevate tervise seisundite üleselt ja nendega saab tutvuda [Mõlema silma pimedus - alusharidus](#).

4.2. PÕHIHARIDUS

Igal lapsel on õigus õppida kodukohalähedases koolis, elukohajärgsel koolil ei ole õiguslikku alust õpet mitte pakkuda. Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond määrab õppekava ja sobilikud meetmed lapse toetamiseks. Igale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava, kus arvestatakse tema erivajadusi. Individuaalse õppekava koostamisel on oluline arvestada, et intellektipuudega laps saaks tunda ennast koolipere liikmena ning osaleda eakaaslastega kooli poolt pakutavates tegevustes.

Kui kerge intellektipuudega laps läheb tavaklassi, tõuseb päevakorrale õppemeetodite küsimus. Nad õpivad lihtsustatud haridusstandardi alusel, omandades 9. klassi lõpuks materjali, mille teised õpilased saavad üldharidusprogrammi raames selgeks 6. või 7. klassi lõpuks.

Igal haridusliku erivajadusega õpilasel (v.a raske ja sügava intellektipuudega hooldusõppe õpilased, kelle nominaalne õppeaeg on 12 aastat), kes vajab täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks ja sotsiaalse toimetuleku parandamiseks, on õigus põhikoolile järgnevas aastaseks lisaõppeks oma koolis. Iga õppimiskohustuslikus eas noor, kes ei ole vastu võetud gümnaasiumi või kutseõppesse, saab koha ettevalmistavas õppes.



4.3. MILLEGA VEEL ARVESTADA?

- **Olenevalt lapsest on vaja klassiruumi teist õpetajat või abiõpetajat. Koolides on oluline tugispetsialistide kohalolek** – logopeed, psühholoog, eripedagoog.
- Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine, tuleb õpilasele koostada riiklikes õppekavades kindlaksmääratud korras **individuaalne õppekava**.
- Kui haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud individuaalse õppekava alusel soovitakse riiklikus õppekavas määratletud õpitulemusi vähendada või asendada või tahetakse õpilast kohustusliku õppeaine õppimisest vabastada, **võib individuaalset õppekava rakendada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel**.
- Direktori või tema volitatud koolitöötaja otsusel **võib haridusliku erivajadusega õpilasele rakendada meetmeid, mille kasutamine ei eelda nõustamismeeskonna soovitust**: nende meetmete hulka kuuluvad tugispetsialisti teenus, individuaalse õppekava rakendamine, pikapäevarühma vastuvõtmine, õpilaskodusse vastuvõtmine.

Põhikoolile peab järgnema kutseõpe, et täiskasvanuna oleks võimalus osaleda töölus.

5. LISAINFO

- Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit: www.evpit.ee
- Rajaleidja: www.rajaleidja.ee
- Alternatiivkommunikatsiooni maailm:
<https://tegevuste.ee/alternatiivkommunikatsiooni-maailm>
- Agrenska Fond: www.agrenska.ee
- Eriolümpia Eesti Ühendus (spordiorganisatsioon intellektipuudega inimestele):
<https://eeo.ee>
- Paralümpiaakomitee (tegeleb erivajadustega inimeste tippspordi edendamisega):
<https://www.paralympic.ee/et>
- Infopunkt omastehoolduse teemadel, sh hooldusvajadusega laste toetamine (teenused, abivahendid, haridus, jõustavad kogemuslood): www.omastehooldusest.ee

5.1. KASUTATUD ALLIKAD

- Ülevaade intellektipuudest: <https://bit.ly/3TORUeR>
- Psüühilise erivajadusega laste küsitlemise juhendmaterjal: <https://bit.ly/4nsJk37>

Harvikaigused

1. TERVISESEISUNDIST ÜLDISEMALT

Haruldaste haiguste puhul on kogu protsess tavahaiguste diagnoosimisest oluliselt keerulisem ning **sageli on tegemist last ja tema lähedasi terve elu mõjutava seisundiga.**

72% harvikaigustest on geneetilist päritolu; 28% on mittegeneetilised, näiteks haruldased vähivormid, infektsioonid ja immuunpuudulikkused. Keskmise **diagnoosi saamise aeg alates sümptomite ilmnemisest on viis aastat, mis tähendab, et laps ja pere on juba enne diagnoosi saamist reeglina elanud läbi palju muret, hirme, kahtlusi ja ebakindlust. Ravi on olemas vaid ca 5% harvikaigustest.** Tõsiasi, et sageli puudub haigusele tõhus ravi, suurendab perede raskused mitmekordseks: lisaks sellele, et lapsel on haruldane haigus, mida on olnud keeruline diagnoosida, ei leidu ka sobivat ravi, või on ravi küll olemas, kuid äärmiselt kallis ja kättesaamatu.

Haruldased haigused põhjustavad lapsele reeglina **erinevaid funktsioonihäireid** ning **mõjutavad oluliselt tema elukvaliteeti**, kuna haiguse krooniline, progresseeruv, degeneratiivne ja sageli eluohtlik olemus tähendavad vähest iseseisvust või selle täielikku puudumist. Geenihaigusest tulenevalt on harvikaigusega lapsed sageli kõnetud või vähese kõnega, liikumisraskustega, kannatavad epilepsia ja teiste krooniliste haiguste all. Aga esineb ka näiteks ainevahetusest tingitud harvikaiguseid, mille puhul laste igapäevaelus osalemine ja toimetulek on tänu elukestva ravitoidu kasutamisele ja range dieedi järgimisele tavapärane. Täiendavat infot ainevahetusest tingitud harvikaiguste kohta saab küsida TÜ Kliinikumi Harvikaiguste Kompetentsikeskusest.

Harvikaigused on ühtepidi haruldased, kuid teisalt puudutavad need märkimisväärset osa rahvastikust, hinnanguliselt **6–8% populatsioonist**, Eestis seega ca 100 000 inimest, sh pereliikmeid, kelle elu on lähedase haigusest mõjutatud. **Valdav osa harvikaigustest diagnoositakse lapsepõlves, mistõttu saavad vanematest lisaks vanemliku rolli täitjatele ka esmased hooldaja rolli täitjad.** 70% lapsevanematest on olnud piisava toe puudumise tõttu sunnitud lapse haiguse tõttu töökoormust vähendama või tööst loobuma.

Selle kõige tõttu on äärmiselt oluline, et last ja pere toetavad **spetsialistid oleksid teadlikud, empaatilised, proaktiivsed ja professionaalsed ning oskaksid peresid parimal võimalikul moel jõustada ja toetada.**

2. HARVIKHAIGUSTE ESINEMISSAGEDUS JA SPETSIIFIKA

Selleks **et saaksid harvikaigusega last kasvatavat peret toetava spetsialistina mõista pere tundeid, läbielatud, väljakutseid ja toetusvajadust ning osata ka jõustavalt suhelda ja abi pakkuda, on oluline hoomata harvikaigustega seotud eripärasid, haiguse avastamise ja diagnoosimise raskuseid ning inimlikke üleelamisi.** Väheoluline ei ole ka harvikaiguste reeglina ultraharv esinemissagedus ja sellega seonduv üksindus, lootusetus ja hirm.

Harvikaiguseid ehk **haruldasi haiguseid on ca 7000–8000.** Haiguste haruldust iseloomustab tõsiasi, et umbes **85% haiguste esinemissagedus on madalam kui üks haige miljoni inimese kohta.** Euroopa Liidus peetakse haruldaseks haiguseks haigust, mis esineb vähem kui 5 inimesel 10 000-st. Euroopas elavast pea 750 miljonist inimesest on harvikaigus ca 30 miljonil inimesel. **70% harvikaigustest saavad alguse lapseas.**

Haruldasi haiguseid iseloomustab sümptomite ja iseloomulike tunnuste suur mitmekesisus, mis varieerub mitte ainult haiguste vahel, vaid ka sama haigust põdevate inimeste vahel. Seega võib üks haigust põdev laps olla näiteks kõnelev, kerge intellektihäire ja väheste liikumiskustega, samal ajal kui teine sama haigust põdev laps on kõnetu ja raske intellektihäirega, vajades liikumiseks käru või ratastooli. **Samuti on haiguseid, mis on ajas progresseeruvad** ja põhjustavad lapse surma enne täiskasvanuikka jõudmist.

Harvikaigusega inimene võib elada kogu elu diagnoosi saamata – on haiguseid, mida ei ole veel avastatud. Küll aga vajab ka diagnoosita laps ja tema pere tuge, nõustamist ja teenuseid. Diagnoosimata laste vanemad on rõhutanud oma ebakindlust ja võimetust plaane teha, mis omakorda mõjutab nii peresuhteid kui ka üldist perekonna heaolu.

Harvikaiguste puhul võib lapsel esineda samaaegselt mitu tervisepiirangut, nt intellektihäire, liikumiskused, tasakaalu hoidmise ja kehataju probleemid, kõnetus, epilepsia, autism, probleemid uinumise ja unespüsimisega; suhtlemispiirangutest tingituna võib esineda ennast või teisi kahjustavat käitumist, häiritud võib olla ohutaju, ka ei pruugi laps suuta närida, neelata, häiritud võib olla kogu seedesüsteem. **Lapsed vajavad pidevat juhendamist, kõrvalabi ja järelvalvet.**



3. HARVIKHAIGUSEGA LAPSE JA PERE TOETAMINE

Kuigi harvikhaiguseid on erinevaid, tähendab **valdav osa neist haigustest peredele suurt, isegi äärmuslikult suurt hoolduskoormust**. Puudega laps mõjutab perekonna toimimist igal tasandil ning hoolduskoormus on stressi ja kurnatuse allikas kõikide pereliikmete jaoks. Piisavas matus sobivate teenuste kättesaadavus on perekonna kui terviku toetamisel keskse tähtsusega.

Omastehoolduse ning hooldaja füüsilise ja vaimse heaolu vahel on tihedad seosed. **Uuringutest on välja tulnud hooldamise kahjulik mõju hooldajate heaolule, eriti sagedased on (krooniline) stress, ülekoormus, kurnatus**. Kahjulik mõju on tingitud hoolduskoormusest põhjustatud pikaajalisest füüsilisest ja psühholoogilisest pingest, samuti ettearvamatuses, määramatuses ja kontrolli puudumisest. Täiendavateks stressiallikateks võivad olla ka muutused sõprussuhetes või nende kvaliteedis, samuti tööturult eemalolek või pingutused töökohast suure hoolduskoormuse kõrvalt kinni hoida.

Sinu jaoks tähendab see oma tööd tehes, et:

- Sa keskendud tervele perele, kavandades koos lapsevanematega sobiva abi ja toe võimalusi. **Kui peres on kasvamas teisigi lapsi, arvestad ka nende õiguse ja vajadusega veeta aega oma ema ja isaga**, osaleda huvitegevuses ning tunda vanemate kohalolu.
- **Sa tead, et lapsevanematel on õigus eneseteostusele ja tööelus osalemisele**. Erinevad peret toetavad sotsiaalteenused peavad aitama tagada, et vanemad saaksid tööl käia ja perele sissetulekut teenida.
- Sa mõistad, et ka lapsevanem vajab puhkehetki ja taastumist nii hooldamisest kui palgatööst. **Sa pakud ennetavalt teenuseid, selgitad nende taotlemist, julgustad teenuseid kasutama, et vältida lapsevanema kurnatuse ja tervise kahjustumist piirini, mil ta ise muutub vähenenud töövõimega abivajajaks**.
- Sa mõistad tervete ja toimivate peresuhete tähtsust ning tead, et ka **harvikhaigusega lapse vanematele tuleb pakkuda pere toimimise tagamiseks aega ja võimalusi**.
- Sa **ei jaga hinnanguid ega halvusta lapsevanema tegevust, oled toetav, aga oskad märgata, kui lapsel ei ole oma kodus turvaline olla ning olukord vajab sekkumist**.
- Sa tead, et **lapsevanem on harvikhaigusega lapse peamine hooldaja ja tugi** ning teda toetades toetad ka lapse igapäevast heaolu ja kodus elamist.

Harvikaigusega lapse vanemad on enne abi otsimiseni jõudmist teinud läbi – ja sageli läbivad veel endiselt – keerulist leina, leppimise ja hakkamasaamise protsessi. Tihti kestavad need protsessid aastaid ja aastakümneid, mis tähendab seda, et lapsevanem, kelle harvikaigusega laps võib küll olla juba näiteks 15-aastane, on endiselt äärmiselt haavatav ning bürokraatlike asjaajamiste rohkus ja jäikus võib teda vaimselt kurnata, lapse järjekordne tervisemure ärevust tekitada, sage öine ärkamine ja pidev magamatus tegevusvõimele, keskendumisele ja tervisele rängalt mõjuda.

Harvikaigusega lapse eest hoolitsemine mõjutab inimese elu paljudes valdkondades, sealhulgas psühholoogilises, majanduslikus, füüsilises ja logistilises. Lapsevanema hea vaimne ja füüsiline tervis on ülioluline tagamaks, et ta suudab säilitada tähtsat rolli, mida ta lapse elus täidab.

Sarnase kogemuse tugi mängib harvikaigusega laste vanemate elus suurt rolli. Kuivõrd sageli ei pruugigi Eestis olla teist sama diagnoosiga last/täiskasvanut, kelle perega kogemusi vahetada või on neid peresid vaid mõned üksikud, osalevad lapsevanemad sotsiaalmeedias tegutsevates rahvusvahelistes gruppides või leiavad asjaajamisel praktilist infot Eesti puudega laste vanemaid koondavatest sotsiaalmeedia gruppidest.

Sinu jaoks tähendab see oma tööd tehes, et:

- **Sa lähtud suhtlemiseetika põhimõtetest,** kasutad jõustavat suhtlemisviisi, oled positiivne, hinnanguvaba, toetav.
- Sa oled **orienteeritud lahenduste leidmisele,** minimeerid bürokraatiat.
- Sa **märkad lapsevanema vajadust vaimse tervise toe järele** ja vanema soovi korral tagad vastava nõustamise.
- **Kontakteerud lapsevanemaga omaalgatuslikult,** tagamaks, et lapsevanem tunneb end hoituna ja veendumaks, et perele antav tugi toimib nii nagu peab.
- Informeerid lapsevanemat puudega laste vanematele mõeldud **tugigruppide tegevusest** või toetad tugigrupi loomist oma piirkonda.
- **Julgustad lapsevanemat** otsima infot ja suhtlema teiste lapsevanematega, sest tead, et lihtsam on rääkida endast ja oma olukorrast teisele samas olukorras olijale.
- Sa tead, et **enese hooletusse jätmisel võivad olla tõsised tagajärjed lapsevanema enda tervisele** ning see mõjutab otseselt ka abivajavat last.

4. SUHTLEMINE HARVIKHAIGUSEGA LAPSEGA

Harvikhaigusega laps on nagu iga teinegi laps – ta on oluline osa oma perekonnast, kogukonnast ja ühiskonnast. Sõltumata sellest, kas harvikhaigusega laps on tavakoolis õppija, intellektipuudega, kõnelev, kõnele reageeriv või siis teiste inimeste vaatest n-ö omas maailmas, tuleb kõiki inimesi kohelda võrdselt, väärikalt, kaasavalt, pöördudes last puudutavates asjades esmajärjekorras tema enda poole. **Olles veendunud, et laps ei saa verbaalselt või muul moel oma arvamust väljendada, kõneletakse lapsevanemaga.**

Sinu jaoks tähendab see oma tööd tehes, et:

- **Sa suhtled lapsega otse, mitte ainult vanema kaudu. Vanemaga suheldes ära unusta ka lapsele tähelepanu pöörata,** ära räägi lapsest kolmandas isikus.
- Tutvustad end lapsele ja võtad kontakti lapsele arusaadaval viisil. Lausud näiteks: „Tere, mina olen Kadi. Vaatame koos, kuidas sul läheb ja mida sa vajad.“
- **Kasutad lapsele arusaadavat keelt,** kasutad tema vanusele sobivat sõnavara või vahendeid ja väldid keerulist ametnikusõnavara.
- Eakohase arenguga lapse puhul on suhtlus tavapärane, arvesse tuleb võtta haigusega seotud eripärasid ning rääkida lapsega tema tundeid riivamata.
- Oled suheldes **positiivne, kannatlik ja julgustav.**
- Sa ei dikteeri, kiirusta ega suuna vastamisel (abistavad küsimused ja selgitused on sobivad).
- Vaata ka [ametniku sekkumise eetika](#) ja [intellektipuude peatükki](#).

5. VAJALIK INFO, TEENUSED, TOETUSED JA MUU ABI

Iga harvikhaigusega laps on enda moodi ja isemoodi vajadustega. Seega tuleb **iga lapse toetamisel lähtuda just tema vajadustest. Oluline on hinnata lapse vajadusi tervikuna, sh võtta arvesse elukeskkonda, kogu perekonda ja mitte ainult näiteks mingit konkreetset terviseprobleemi.**

Sõltuvalt lapse harvikhaiguse väljendumisest võib tema ja pere vajadus erinevate teenuste järele olla väga erinev. See võib olla pigem vähene ja piirduda vaid näiteks regulaarse meditsiinilise jälgimise, sobivate ravimite ja taskukohase hinnaga eritoidu kättesaadavuse tagamisega ning psühholoogilise toe pakkumisega. Kuid **abi- ja toetusvajadus võib olla ka äärmiselt suur, mis tähendab, et laps ja pere vajavad tuge nii tervishoiu-, sotsiaal- kui ka haridussüsteemist, lisaks on vaja rakendada tööturumeetmeid, tagatud peaks olema igakülgne ligipääsetavus nii avalikus kui inforuumis jne.**

On väga oluline, et lapse juhtumiga tegelev **spetsialist oleks kompetentne ja pädev peret nõustama ning juhendama erinevate toimetulekut toetavate ja hoolduskoormust leevendavate võimaluste osas**. Näiteks erinevate abivahendite loetelu on pikk ja lapsevanem ei pruugi, eriti teekonna alguses, paljusid asju teada ega suuta ka nende peale mõelda. Geenimutatsioonist tingitud harvikaiguse, mis mõjutab lapsel nii kognitiivset kui ka füüsilist tasandit, puhul võivad osutuda vajalikuks liikumisabivahendid (käru, ratastool), seisulaud, turvaiste, ortoosid, ortopeedilised jalanõud, põlled, surveriided, mähkmed, hügieenivahendid, (libi)linad, kommunikatsiooniseadmed, sh silmjuhitavad kommunikaatorid, tõstukid ja laesiinid jms. Samuti võivad olla igapäiselt vajalikud hapnikuaparaat, aspireerimisaparaat ja sobivad (hooldus)vahendid mitte-suukaudse toitumise korral. Nimekiri võimalikest abivahenditest on pikk ning vajadus sõltub lapsest. Täpsemad soovitusel saab perele anda abivahendi ettevõtte või kui laps kasutab rehabilitatsiooniteenuseid, siis rehabilitatsioonispetsialist.

Samuti sõltub last ja peret toetavate **teenuste vajadus lapse erivajaduste ulatusest, aga ka pere toimetulekust, laste arvust, elukeskkonnast ja elupaiga asukohast**. Suure abi- ja toetusvajadusega harvikaigusega laps võib vajada **erinevate teenuste kombinatsiooni**, näiteks rehabilitatsiooni teenust ja erinevaid muid teraapiaid, tugiisikuteenust, lapsehoiuteenust, intervallhoiuteenust, sotsiaaltranspordi ja kodu kohandamist. Kõik teenused panustavad lisaks lapse toetamisele ka kogu pere toimimisse. **Teenuste vajadus on suure tõenäosusega püsiv ning oskuste säilitamine ja nende arendamise tulemuslikkus sõltub järjepidevusest**.

Spetsialistina on sul tähtis roll, et vajalik tugi jõuaks pereni:

- **Tutvusta perele erinevaid abi saamise võimalusi**, sh teiste sektorite poolt pakutavat, jaga kontakte, nt TÜ Kliinikumi Harvikaiguste Kompetentsikeskus, rehabilitatsiooniteenused.
- Lapsevanem ei pruugi abi taotledes teada, millist teenust (teenuseid) pere vajab, spetsialisti kohustus on võimalusi tutvustada ja pakkuda, **lubamatu on öelda: "Aga pere ise ei küsinud seda teenust!"**
- Vii läbi **põhjalik vajaduste hindamine**, sh küsi ka teiste pereliikmete vajaduste kohta (nt võib teenuste vajadus olla suurem, kui peres on teisigi lapsi, kes vanemate tähelepanu vajavad; vanematel võib olla soov psühholoogilise abi järele jne).
- **Kontakteeru perega ka kohtumiste/pöördumiste vahelisel ajal** (nt kord poole aasta jooksul), anna märku, et oled spetsialistina olemas ja julgusta vajadusel ühendust võtma.
- **Mõista, et lapsevanema igapäevasele (ja tihti ka -öisele) hoolduskoormusele lisandub lapse teenuste, ravi, hariduse ja erinevate spetsialistide visiitide korraldamise, taotluste täitmise, suhtlemise ja info vahendamise koormus. Ole toetav.**
- **Hoia kontakti ka teiste lapsega tegelevate spetsialistidega**, veendumaks, et lapse õigused ja heaolu on tagatud.

6. ÕPPE KOHANDAMISEGA SEOTUD BAASVAJADUSED

Harvikaigusest, selle mõjust ja erivajadus(t)e ulatusest sõltub ka lapse haridustee. **Ei ole oluline, kas laps on erivajadusega või mitte – igal lapsel on koolikohustus ja õigus omandada haridust kodukohalähedases koolis.**

Kui harvikaigus ei ole lapse õppimisvõimet liigselt mõjutanud, saab laps õppida riikliku õppekava järgi ning osaleda tavapäraselt või kohanduste abil igapäevases õppetöös. Näiteks ainevahetushaigus fenüülketonuuria, mille varase diagnoosimise ja edasise järjepideva dieetravi korral on lapsel enamasti tavapärane intellektitase ja ka elukvaliteet, puhul saab hariduse omandamine toimuda tavaprogrammi alusel. Arvestada tuleb dieedist tulenevate erivajadustega lasteaia- ja koolisöögi pakkumisel. Eluaegse range dieetravi järgimine on vaimselt koormav nii perele kui ka lapsele ning vajalik võib olla soovi korral psühholoogiline tugi. Sõltuvalt lapse seisundist võib olla vaja pakkuda ka sotsiaal- ja tervishoiuteenuste tuge ning erilähenemist haridussüsteemis.

Harvikaigusega **lapsed, kellel on haigusest tulenevalt suur hooldusvajadus, kuid tavapärane intellektitase, peavad saama käia koolis**, kui tervises seisund seda võimaldab (nt kui kokkupuude võimalike nakkustega vms ei ole eluohtlik). Näiteks haigused, mille tõttu laps vajab liikumiseks ratastooli (haruldased lihashaigused, nt Duchenne'i lihasküstroofia), ei tähenda, et laps peaks olema koduõppel. Laps peab saama omandada teistega võrdselt haridust, sh vahetus koolikeskkonnas. Tagatud peavad olema vajalikud **tugiteenused** (nt tugisik, isiklik abistaja, kooliõde) ning samuti peab **olema ligipääsetav ja kohandatud keskkond**.

Sageli mõjutavad geenimutatsioonist tingitud harvikaigused lapse intellekti, õppimise ja suhtlemise võimekust. Sellisel juhul tuleb lapsele pakkuda sobiv lasteaiakoht väiksemas ja eriväljaõppe saanud personaliga lasteaiarühmas ning kooliminekul tuleb leida sobiv õppekava lihtsustatud õppekavade kolme variandi hulgast: lihtsustatud õppekava, toimetulekuõppe õppekava või hooldusõppe õppekava (vt [Intellektipuue- õppe kohandamisega seotud vajadused](#)). Nii alushariduse kui ka põhihariduse omandamise käigus tuleb sobiv õpperühm või õppekava vajadusel ümber vaadata.

Spetsialist peab seisma selle eest, et ükski lapsevanem ei peaks sobiva lasteaia- või koolikoha pärast lisamuret tundma. **Kui info harvikaigusega lapsest jõuab kohaliku omavalitsuse vaatevälja ja töölauale, tuleb vanematega koostöös kohe hakata tegelema lapse kodukandis ka sobiva lasteaiakoha/koolikoha otsimise, kohandamise või rajamisega.**

7. LISAINFO

- Eesti Puuetega Inimeste Koda: www.epikoda.ee
- Infopunkt omastehoolduse teemadel, sh hooldusvajadustega laste toetamine (teenused, abivahendid, haridus, jõustavad kogemuslood): www.omastehooldusest.ee
- Rajaleidja: www.rajaleidja.ee
- Tartu Ülikooli Kliinikumi Harvikaiguste kompetentsikeskus: www.kliinikum.ee/harvikaigused
- Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond: www.lastefond.ee
- Eesti Agrenska Fond: www.agrenska.ee

7.1. KASUTATUD ALLIKAD

- What is a rare disease? EURORDIS-Rare Diseases Europe: www.eurordis.org/information-support/what-is-a-rare-disease/
- Tartu Ülikooli Kliinikumi Harvikaiguste kompetentsikeskus: www.kliinikum.ee/harvikaigused
- Raske või sügava intellektipuudega harvikaigusega last kasvatavate perede olukorrast Eestis. Ettepanekud harvikaigusega last kasvatavate perede toetamiseks. Magistritöö. Maarja Krais-Leosk: tai.ee/et/sotsiaaltoe/millist-tuge-vajavad-harvikaigusega-last-kasvatavad-pered

Autismi raskemad vormid (autism ja intellektipuue)

1. TERVISESEISUNDIST ÜLDISEMALT

Rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon viitab, et autismspektri häire on seisund, kus on erinevused kahes valdkonnas:

- **Sotsiaalne suhtlus ja kommunikatsioon:** arusaamine olukordadest ja teistest inimestest on eripärane, nagu ka enda väljendamine ja teistele arusaadavaks tegemine.
- Autismspektri häirele on omane **korduv käitumine, omapärased huvid** (kitsas keskendumine mingile ühele huvipakkuvale teemale) ning **sensoorsed eripärad**.

Autismspektri häire on püsiv seisund ja selle teke on seotud enamasti geenidega. Nüüdisajal saab autismspektri häirega inimestest 10% puhul tuvastada kindlad põhjused. Need hõlmavad geneetilisi häireid (fragiilse X-i sündroom, neurofibromatoos, tuberoosne skleroos, Angelmani sündroom, Cornelia de Lange'i sündroom, Downi sündroom, ravimata fenüülketonuuria), kromosoomi ümberpaiknemist (märgatav karüotüübis) või haruldasi keskkonnamõjusid (sünnieelne kesknärvisüsteemi infektsioon, tingituna punetistest või tsütomegaloviirusest, sünnieelne kokkupuude valproehappe või talidomiidiga).

Uuringute põhjal esineb maailmas autismi ja autismsarnaseid arenguhäireid 1% lastest ja noorukitest. Meessoost isikutel diagnoositakse autismi 3–4 korda sagedamini kui naissoost isikutel.

Oluline on eristada intellektipuudega autisti ja eakohase intellektiga autisti, sest nende võimed, vajadused, eripärad ja suhtlemine on väga erinevad (vt ka [Intellektipuue](#)).

Intellektipuude ja autismspektri häirega inimesega töötades tuleb tegevuste valikul lähtuda inimese kognitiivsest võimekusest, juhendamisevõtete rakendamisel aga emotsionaalsest east.



2. SUHTLEMINE AUTISMISPEKTRI HÄIREGA JA INTELLEKTIPUUDEGA LAPSEGA

Intellektipuude ja autismispektri häirega kaasub sageli raskesti mõistetav käitumine, näiteks häälitsemine, kajakõne, endasse sulgumine, sundliigutused jmt. See võib ootamatult üle minna äärmuslikuks kahjustavaks käitumiseks, mis võib avalduda röökimisena, **esemete loopimisena, lõhkumisena, verbaalse või füüsilise agressiooniga teiste inimeste suhtes või ennasthävitava käitumisena.**

Käitumine on alati kommunikatsiooni vorm, millel on tähendus. Iga käitumisega püüab inimene midagi öelda. Nii raskesti mõistetav käitumine kui ka äärmuslik kahjustav käitumine on viisid paluda abi ja väljendada mingit olulist rahuldamata vajadust – näiteks kui laps ei tule toime uue ja stiimuliterohke olukorra või keskkonnaga. Autismispektri häire mõjutab just võimet mõista olukorda ja enda vajadusi ning neid väljendada, seega on lapsega töötaval täiskasvanul oluline interpreteerida ka raskesti mõistetavat, “probleemset” või “väljakutsuvat” käitumist esmajoones abipalvena ning püüda mõista, milles probleem või vajadus seisneb.

LUGU 1. PSÜHHIAATER

13-aastane autismispektri häire ja mõõduka intellektipuudega kirjaoskamatu poiss oli koos emaga psühhiaatri vastuvõtul. Selle psühhiaatri juures oli see esimene visiit. Ema rääkis kogu lapse eluloo, probleemidest koolis (raskesti mõistetav käitumine), terviseseisundist. Visiidi eesmärgiks oli puude pikendamine. Visiidi lõppedes pöördus arst lapse poole ja palus, et ta dokumentidele alla kirjutaks. Võõra inimese pöördumisest poiss tardus, mille peale arst hakkas emalt nõudma, et too midagi teeks, kuna nad ei tohtinud lahkuda ilma noormehe allkirjata.

Noormehe mõõtu poiss ei osanud lugeda ega kirjutada, tal puudus võimekus mõista dokumentide sisu või sellele allkirja anda ning kognitiivselt ja emotsionaalselt arengult oli ta endiselt 4–7-aastase lapse tasemel. Sellele lisandus autismispektri eripärast tulenev vajadus selguse ja ennustatavuse järele. Kontakti ja usalduse loomine on pikaajaline protsess, mida tasub ette võtta siis, kui autist jääb töötaja vaatevälja pikemaks ajaks. Poiss keeldus edaspidi seda spetsialisti külastamast.

Mida oleks spetsialist või asutus saanud teha selles olukorras teisiti?

Võti kontakti loomisel on autismitaadlikkus ehk autismi eripärade teadvustamine ja mõistmine ning nendega arvestamine töös lapse ja perega.

Selleks, et autist situatsiooniga hakkama saaks, peab ta teadma, MIS on tema ülesanne, KUIDAS ta seda peab tegema, KUS ja MILLAL see toimub ja KES on sinna kaasatud, ja seda kõike tuleb esitada talle arusaadaval viisil.

Pea meeles enne lapsega kohtumist:

- Kui on kindlasti vajalik, et koos vanemaga tuleks vastuvõtule ka laps, siis on hea enne konsulteerida vanemate või lapsega töötavate spetsialistidega, milline on talle turvaline keskkond, millised sensoorsed eripärad võivad teda mõjutada ja milliseid kommunikatsioonivahendeid ta kasutab.
- Pea täpselt kinni lapsele ja perele eraldatud vastuvõtu ajast, sest autismispektri häirega laps vajab selgust, struktuuri ja ennustatavust ja tal on raske oodata. Näiteks, ka piktogrammidega harjunud laste puhul on ooteaeg "oota"-piktogrammi kasutades mitte rohkem kui 10 minutit.
- Küsi, kas on olemas eelinfo teenusele/visiidile saabuva lapse kohta, vajadusel koosta see.
- Võimalusel kohanda keskkonda või vali kontakti toetav keskkond. Autisti jaoks on lihtsam kohaneda keskkonnas, kus on **vähe erinevaid stiimuleid**. Paremini sobivad **kinnised kapid või kaetud riivlid, neutraalsed värvid, mahe valgus, vaikus või heli summutavad abivahendid**.
- Määramatu olukord autisti jaoks on ka see, kui ema vastab pikalt küsimustele ja tema samal ajal viibib talle võõras ruumis, võõra inimesega, teadmata, mida temalt oodatakse, mis edasi saab ja kaua see kestab.

Esimesel kohtumisel ja kohtumise alguses:

- Anna aega ja lase lapsel omas tempos keskkonda uurida.
- Lase end distantsilt jälgida.
- Kui sinu koostöö selle lapsega kujuneb eeldatavalt pikaajaliseks, siis esimene kohtumine võiks kesta 5 kuni 10 minutit, nii et laps esialgu lihtsalt tuleks kohale, tutvuks ja harjuks sinuga, sinu välimuse, hääle, lõhna, ruumiga jmt.



Autismispektri häire ning sügava ja raske intellektipuudega lapse puhul **kasuta esmase kontakti saamiseks tunnetusliku suhtlemise meetodit:**

- Ole lapsega koos, lase tal ennast jälgida, loo silmside (kui laps seda talub), jälgi tema miimikat, kehakeelt, hääletsusi.
- Emotsionaalse kontakti saavutamiseks jäljenda tema enda kehakeelt ja/või hääletsusi.
- Kui edukas esmane kontakt on loodud, võimalda kordamööda tegutsemist. Selle meetodi peamiseks eesmärgiks on usaldusliku suhte loomine.

Näiteks: Sügava intellektipuudega laps nuhutab käsi ning häälitseb: "amm-amm", esmase kontakti loomiseks jälgime teda ja siis jäljendame tema käitumist. Anname talle aega, et ta harjuks meiega.

Oluline on silmas pidada, et kui esimene kohtumine on lapsele kognitiivselt ja emotsionaalselt kurnav (vaata selgitusi eespool), ei pruugi laps enam vastuvõtule/lasteaeda/kooli tulla. Seega on väga oluline, et keskkonda, autisti ja tema peret valmistataks kohtumiseks ette (põhimõtted eespool).

3. KUIDAS TOETADA LAST JA TEMA PERET?

LUGU 2. ERIHOOLEKANDETEENUS

Erihoolekandeteenusele jõudis kõnetu raske intellektipuudega 18-aastane autistist noormees. Ta oli olnud 18 aastat erinevate spetsialistide vaateväljas, käinud lasteaias ja koolis ning erinevatel teenustel, kuid ei osanud süüa, peput pühkida, käsi pesta ega lasknud seda ka teistel teha. Ta väljendas end intensiivse kahjustava käitumise kaudu, sest tal ei olnud ühtegi alternatiivset viisi end väljendada. Aasta jooksul õppis ta iseseisvalt sööma, kohanes mitmekesise menüüga, lubas võõrastel aidata eneseabitoimingutes ning õppis väljendama esmaseid baasvajadusi.

Võti lapse ja pere toetamisel on autismitaadlikkus ehk autismi eripärade teadvustamine ja mõistmine ning nendega arvestamine. On oluline, et **autist õpiks ennast väljendama ja enda eest hoolitsema. Arvestama peab, et autistil on:**

- 1) vajadus selguse, struktuuri ja ennustatavuse järele;
- 2) initsiatiivi puudumine;
- 3) ülitundlikkus ja alatundlikkus.

Pea silmas ka seda, milline on kaasnev intellektipuue ning lapse emotsionaalne ja kognitiivne võimekus, mis omakorda võimendab autismispektri häirega kaasnevaid väljakutseid.

3.1. TOETA PERET, ET PERE SAAKS TOETADA LAST

Pea silmas, et:

- Pere jaoks on autismi diagnoos suur šokk ja kogemus näitab, et paljud ei tule sellest ise välja ning jäävad leina ja eituse faasi aastateks või aastakümneteks.
- Pere vajab esmalt ise emotsionaalset toetust selleks, et ta suudaks olla lapsele toeks ja luua autistile sobiva selge, struktureeritud ja tema erivajadust arvestava keskkonna (sh suhtlemine ja juhendamine).
- Teadmine autismist tervishoiu- ja haridussüsteemi spetsialistide seas on ebaühtlane.

3.2. ESMANE TOETUS

Kui on olemas esmane kahtlus või ka juba diagnoos, siis vajab kogu pere mitmekülgset tuge.

Praktikas tähendab see:

- Kogemusnõustamist või suhtlust ja kogemuste vahetamist teistega, kes on (või on olnud) sarnases olukorras.
- **Psühholoogilist nõustamist** ehk psühhiaatri/psühholoogi soovitusi ja nõuandeid lapsega suhtlemiseks ning selle kohta, kuidas edasi tegutseda ning samuti toetust lapsevanematele uue olukorraga toime tulekul.
- **Infot diagnoosi kohta.** Seda saavad anda perearst, psühhiaater, vaimse tervise õde, spetsialistid kohalikust omavalitsusest, liidud ja ühingud, samuti eesti- ja muukeelsed sotsiaalmeediagrupid.
- **Kohaliku omavalitsuse spetsialistide nõuandeid ja toetust:** kuhu pöörduda abi saamiseks; vajaduse korral võib peret aidata, võttes osa ülesandeid enda kanda – näiteks taotluste täitmine, info küsimine, aja broneerimine vms; võib uurida järele, millisesse lähedalasuvasse asutusse (lasteaiad, koolid, lastelaagrid) laps sobiks, millised on võimalused.
- **Koolitusi diagnoosi eripärade kohta emale/isale ja teistele lähedastele** läbi elukaare ehk lasteaia-, kooli-, nooruki- ja täiskasvanueas.
- **Koolitusi alternatiivkommunikatsiooni vahenditest (AAC – augmentative and alternative communication)** ja nende kasutamisest (seda saavad pakkuda rehabilitatsioonispetsialistid).

3.3. VANEMATE TOETAMINE OMA LAPSE MÕISTMISEL, JUHENDAMISEL JA ARENDAMISEL

Võti lapse toetamiseks on varane sekkumine.

Praktikas tähendab see:

- Intellektipuude ja autismispektri häirega lapsele on esmatähtis tema jaoks välja töötatud ja talle selgeks õpetatud **alternatiivkommunikatsiooni vahend**, mis annab talle võimaluse end väljendada. See aitab hilisemas elus vähendada või koguni vältida nii raskesti mõistetavat käitumist kui ka äärmuslikku kahjustavat käitumist. Sobiva vahendi aitab leida ja lapsele selgeks õpetada tegevusterapeut või logopeed ning seda peavad lapsega suhtlemisel kasutama kõik lapsega kokku puutuvad inimesed.
- Teiseks on autistlikule lapsele oluline juba väikelapseeest **õppida sotsiaalseid oskuseid**, mõistagi talle sobivas keskkonnas. See hõlbustab hiljem koolis ja igapäevaolukordades hakkama saamist.
- **Tuleb koostada sensoorne profiil**, et välja selgitada, kas ja millises ulatuses mõjutavad sensoorse integratsiooni probleemid lapse igapäevaelu. Seda saab teha eripedagoog/tegevusterapeut, kes hindab tegevusvõimet, selgitab välja sobiliku suhtlemisvahendi ja õpetab seda kasutama, ühtlasi õpetab eluks vajalikke oskusi nagu tualeti kasutamine, söömine, korralik käte- ja hambapesu, ootamise õppimine, kasutades taimerit või "oota"-kaarti jpm.
- Raskesti mõistetava ja äärmusliku kahjustava käitumise esinemise korral peab olema võimalus saada **turvalise füüsilise ohjeldusmeetme kasutamise väljaõpet** (Verge-metoodika) ning käitumisekspertide teenust (nagu HENK) ehk käitumise eesmärkide analüüsimist ja vastavat sekkumist ennetavaks juhendamiseks.
- **Vaja on lapse arenguprofiili ja ohumärkide plaani**, mis koostatakse lapsevanema, teenusepakkuja ning kooli koostöös ja kus saab osaleda kohaliku omavalitsuse esindaja (laste heaolu spetsialist). See dokument võiks olla lapsega suhtlevatele inimestele kättesaadav või käia lapsega alati kaasas. Arenguprofiili ja ohumärkide plaani tuleb uuendada lapse arengust ja analüüsitud situatsioonidest lähtudes, et ennetada olukordi, mis võivad põhjustada äärmuslikult kahjustavat käitumist.
- **Koostada nimekiri meelisasjadest, lemmiktegevustest ning autistile sageli omastest tegevustest, ilma milleta ta olla ei saa.** Meelisasjad aitavad last motiveerida ja nendega saab teda tegutsema meelitada, aga ka tema jaoks ebameeldivaid tegevusi läbi viia – näiteks küüsi lõigata, vereproovi anda, laua taga õppida, igapäevaelu oskusi harjutada jne. NB! Selleks on oluline last tunda. Teda tundmata ei ole võimalik meelisasju ja -tegevusi välja mõelda ning võidakse tagasipöördumatult eksida (st, et autisti on võimatu mõnes konkreetses olukorras koostööle saada).

3.4. JÄRJEPIDEV TUGI TEENUSTE NÄOL

Intellektipuudega autist vajab kõrvalabi ja äärmusliku kahjustava käitumise puhul ka tugevdatud järelevalvet elu lõpuni. **Elukaare esimeses osas on oluline roll perel, kes vajab sellega hakkama saamisel professionaalset ja autismiteadlikku tuge. Täiskasvanuks saades abivajadus jätkub.**

Praktikas tähendab see:

- **Koolitatud ja välja õpetatud tugiisikuid.** Intellektipuudega autist vajab pidevat ja mõningatel juhtudel tugevdatud järelevalvet, samuti suunamist, tegevuste õpetamist, julgustamist, tegevuste ülevõtmist ja ümbritseva „tõlkimist“ igal ajahetkel. Tugiisikuid oleks tarvis mitu, et laps liigselt ei klammerduks ega kiinduks. **Intensiivse äärmuslikult kahjustava käitumise korral võib olla tarvis koguni kolme tugiisikut korraga.** Tugiisik on toeks harjumisel lasteaia või kooliga esimestel kuudel/aastatel ja väljaspool n-ö tööaega. Ta saab peret toetada ja saata nii kodus kui ka väljaspool, näiteks arsti juures, ametiasutustes, poes, kohvikus jne. Tugiisik on kindlasti vajalik perele, kus on teisigi lapsi. Sageli tunnevad pere teised lapsed end kõrvalejäetuna ja kogevad oma äärmuslikult käituvat õe/venna tõttu hirmu, isegi traumakogemuseni välja. Autismispektri häire ja intellektipuudega laps vajab tugevdatud järelevalvet ja tegelemist 24/7, mistõttu pere teised liikmed jäävad paratamatult tagaplaanile.
- **Hingetõmbepause,** et lapsevanemad saaks ka pere teistele lastele tähelepanu jagada ning nendega aega veeta. Lisaks vajavad lapsevanemad hingetõmbepause ka endale.
- **Perearsti,** kes on kursis intellektipuude ja autismi olemusega ning kaasnevate terviseseisunditega nagu epilepsia, tserebraalparalüüs, seedetrakti häired; oskab anda nõuandeid ja soovitusi, näiteks nõustada toitumis-, une- ja meeleajaprobleemide (üli- ja alatundlikkuse) korral. Oluline on silmas pidada, et sageli mõjutab toimetulekut ka kaasnevate haiguste, intellektipuude ning autismi koosmõju.
- **Võimalusel eelistada lasteaia või koolis kohapealseid spetsialiste** (eripedagoog, tegevus- ja loovterapeut, logopeed, käitumisekspert, muusikaterapeut, füsioterapeut). Juhul kui kohapealseid spetsialiste napib, on lapse jaoks oluline koolitatud tugiisik, kes käib lapsega kooli- või lasteaiavälises teraapiakabinetis tööpäeva jooksul.
- **Võimalust veeta aega laagrites** lasteaia või kooli suvepuhkuse ning lapsevanemate puhkuse ajal. Kohalikud omavalitsused peavad vastavalt lapse abivajadusele tagama suure hooldus- ja abivajadusega lapse hoiu teenuse.
- **Vajaduse korral pere materiaalsel toetamisel.**
- **Vanema tööturul püsimise toetamist** – tagada lapsele lasteaia- või koolikoht.

3.5. TOETUS ARSTIABI SAAMISEL JA UURINGUTE TEGEMISEL

Pea silmas, et

- Autist ei oska sageli teistele üheselt mõistetavalt väljendada, et ta tunneb end halvasti või et tal kuskilt valutab;
- autist ei pruugi ise aru saada, kust tal valutab – tema aju ei vii seda kokku;
- ka äärmuslik kahjustav käitumine ehk “plahvatused” võib olla autisti jaoks viis väljendada seda, et ta ei tunne end hästi või et tal kuskilt midagi valutab.

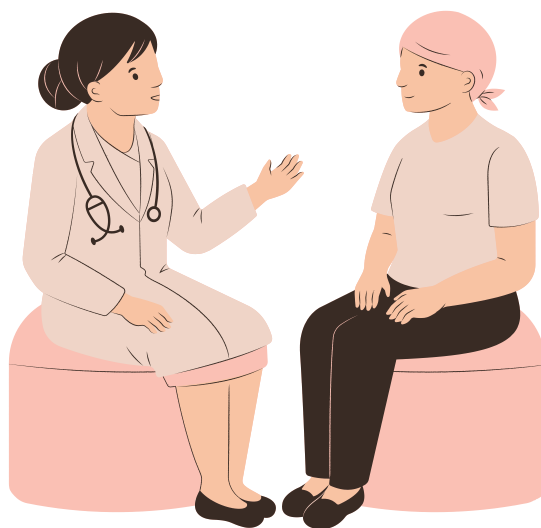
Autismispektri häire ja intellektipuudega lapse ja tema pere toetamiseks on oluline **regulaarne tervisekontroll ning valmisolek teostada uuringuid autisti vajadusi arvestades.**

Autismispektri häire puhul võib esineda erinevaid kaasuvaid haiguseid, samuti võib erinevate ravimite pikaaegsel (koos)mõjul tekkida erinevaid probleeme organites ja verekeemias.“

Kogemus näitab, et raskesti mõistetava ja äärmusliku kahjustava käitumisega autistide tervisekontrollidest tihti hoidutakse või lükatakse neid edasi, sest nii vanematel kui lapsega töötavatel spetsialistidel puuduvad enamasti oskused autiste juhendada ja vajadusel ohjeldada. Võõras keskkond ja võõrad inimesed tekitavad hirmu ja segadust ning selle tulemusena võib avalduda ka äärmuslik kahjustav käitumine. Soovitus oleks tervishoiuspetsialistidel koolituda Verge metoodikas, et õppida toime tulema füüsilise agressiooniga, samuti viia end kurssi autismi teemadel, mille osas saavad aidata nt Autistika keskus või HENK käitumiseksperdid.

Kogemus näitab, et kui **keskkond kohandatakse autisti vajadustele**, kasutatakse sobivaid juhendamisevõtteid – sh piktogrammide, lihtsad ja täpsed juhised, autistile sobiv preemia –, ja autistiga on kaasas inimesed, kes teda hästi tunnevad ning oskavad kasutada ka turvalise füüsilise ohjeldamise võtteid, siis **on võimalik vajalikud protseduurid läbi viia.**

Muu maailma kogemusel viiakse protseduurid vajadusel läbi autistile tuttavas ja turvalises keskkonnas – nt vereproovide võtmine, vererõhu mõõtmine, kuulamine jm lihtsamad toimingud on tehtavad portatiivsete või kiirabi käsutuses olevate vahenditega.



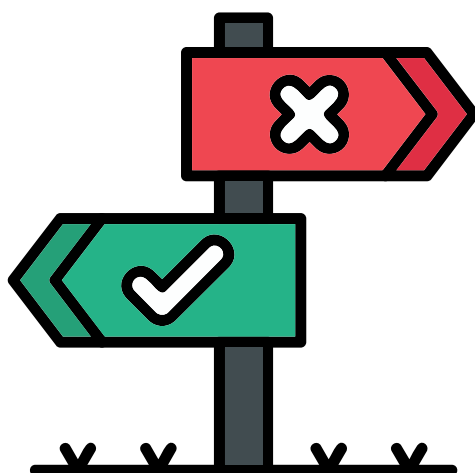
3.5.1 KUIDAS EI PEAKS?

LUGU 1. HAMBARAVI

Asutus palus, et ema läheks 18-aastase noormehega hambaarsti juurde ja laseks hambad korda teha, kuna kahtlustati, et valutavad hambad võivad põhjustada hiljutist intensiivset äärmuslikku kahjustavat käitumist. Ema põikles ja lõpuks tuli välja ka selle põhjus. Selleks, et narkoosi all saaks hambaravi teha, tuleb minna hommikul söömata-joomata elavasse järjekorda, mille pikkus ei ole teada. Ema kartis, et söömata-joomata tunde oodates võib laps plahvatada, sest varem oli lapsel samamoodi elavas järjekorras oodates ilmnenud äärmuslik kahjustav käitumine – hoolimata sellest, et ravisutusele oli teada, et laps peab tulema kohale teisest linnast, tal on autismispektri häire ja talle on omane äärmuslik kahjustav käitumine.

LUGU 2. VEREANALÜÜS

Kõnetu noormees, kellele oli omane intensiivne äärmuslik kahjustav käitumine, oli varasest lapsepõlvest peale saanud erinevaid ravimeid. Asutuses selgus, et üheksandast eluaastast alates 14 aasta jooksul ei olnud talle tehtud ühtegi vereproovi ega tervises seisundi hindamist, kuigi ühe ravimi kasutusjuhendi järgi tulnuks regulaarselt jälgida maksanäitajaid. Kui koostöös teenuseosutajaga tehti vereanalüüs, selgus, et ravimid olid mõjutanud juba erinevaid elundeid (maks, neerud) ning verenäitajaid. Uuringu järel vahetati välja ravimid ning anti lisaks toetavaid ravimeid ning ajapikku vähenes ka vahepeal intensiivistunud äärmuslik kahjustav käitumine.



3.5.2 KUIDAS VÕIKS?

LUGU 3. VEREANALÜÜS

16-aastane autismispektri häire ja mõõduka intellektipuudega kõnetu poiss, kellele oli omane äärmuslik kahjustav käitumine, pidi andma vereproovi. Arst tuli koju, neli inimest hoidsid kinni ja fikseerisid noorukit põrandal. Ema: "See olukord kahjustas last ja emana ei osanud ma teda sellel hetkel toetada."

Sama protseduur neli aastat hiljem, kui poiss oli 20-aastane. Ema osales autismialastel koolitustel, oli ennast põhjalikult ette valmistanud, kuidas luua selgust ja anda motivatsiooni, et protseduur õnnestuks. Emal võttis poja ette valmistamine aega umbes kaks nädalat – selle aja jooksul vaatasid nad Youtube`ist videoid, kuidas lapsed vereanalüüsi annavad. Iga kord, kui ema koos pojaga videot vaatas, luges ta talle ühte ja sama lugu: liblikas lendab käele ja annab talle süüa. Ühel hetkel tundis vanem, et on aeg astuda järgmine samm, ning ta küsis: "Kas annad liblikale süüa ja siis saad kooki?" Poeg oli uudishimulik ning järgmisel korral astus ta vabatahtlikult arstikabinetti ja istus toolile. Ema hoidis visiidi jooksul koogi piktogrammi ja ütles rahulikult: "Annad liblikale süüa".

LUGU 4. KILPNÄÄRME ULTRAHELIIURING

20-aastasele noormehele oli vaja teha kilpnäärme uuring, tal ei olnud protseduuriga varasemat kogemust. Ema näitas pojale protseduurist videoid. Kui uuringu päev kätte jõudis, ütles ema pojale lihtsalt, et läheme autoga sõitma, mis oli poja meelistegevus. Kuna polikliinik oli juba tuttav koht, siis järgnes poeg emale. Ootamisel kasutas ema "oota"-piktogrammi (ennustatavus). Ema juhendamisel läks noormees ilusti kabinetti ja heitis protseduurilauale. Varasemalt oli ema andnud arstile juhised, et poja näopiirkond on tundlik ning palus sellega arvestada ja anda lapsele aega. Samuti palus ema näidata esmalt käe peal, kuidas aparaat töötab, sest geel võib olla esialgu võõras, kui see nahale kantakse. Lisaks oli emal kaasas kiirabi mudelauto, mis oli poja lemmik (selgus, sest arstid sõidavad selle autoga). Ema andis auto poja kätte ja ütles, et arst sõidab ka sellega – nii oli poja tähelepanu täielikult autol ja tänu sellele suutis ta protseduuri taluda. Protseduuri ajal aitas veel ka numbrite loetlemine ühest kümneni, mis andis selguse, kaua veel läheb. Arst oli toetav, lubas protseduuri lõpus poisil istuda ja näitas ekraanil toimuvat ning kinnitas ema sõnu, et sõidab kiirabiautoga. Kogu protseduur oli pojale talutav ja ühtlasi väga positiivne kogemus. Samuti oli arstiga kokkulepe, et kui ta keeldub ja toime ei tule, katkestatakse protseduur kohe.

Uksest väljudes andis ema pojale koogi piktogrammi ja kiitis teda.

3.5.3 SOOVITUSED ARSTIVISIITIDE KORRALDAMISEKS

- **Iga uus inimene, koht ja olukord on autisti jaoks hirmutav ja keeruline** – tavainimese jaoks lihtsas olukorras on tema jaoks liiga palju infot ja stiimuleid, mida ta ei suuda töödelda. Sellest tekib ärevus, millest võib välja kasvada raskesti mõistetav käitumine või äärmuslik kahjustav käitumine.
- Kui tahad, et autist uue inimesega tutvuks ja harjuks, siis **ideaalis võiks esimene kontakt kesta 5 kuni 10 minutit, et ta lihtsalt harjuks uue inimesega – tema välimuse, hääle, lõhnaga.**
- Arsti (sh hambaarsti) juures käimist, vereproovide ja teiste erinevate uuringute jms teha laskmist tasub hakata harjutama juba varakult ja teadlikult, sest neid vajab inimene läbi elu. **Esimesed visiidid arsti (hambaarsti) juurde tuleks teha siis, kui valu veel pole.**
- Luba kaasa võtta lapsele **oluline turvaese**: spinner, kivi, telekapult, kalkulaator vms.
- Samas on oluline, et **vastuvõttude korraldus arvestaks autistide vajadustega** – näiteks ei peaks intellektipuude ja intensiivse äärmusliku kahjustava käitumisega autist ootama söömata ja joomata tunde elavas järjekorras stiimuli- ja inimrohkes keskkonnas, kui tema üks baasvajadusi on pikka aega täitmata. Sellest vallanduv äärmuslik kahjustav käitumine on traumaatiline nii talle, perele kui ka meditsiinitöötajatele, kahandades tema võimalusi edaspidi arstiabi saada.
- Autistist lapse vajadustega arvestamisel on oluline:
 - vastuvõtu ajast kinnipidamine, kuna ootamine stiimuliterohkes keskkonnas on lapsele keeruline;
 - lapsele sobiva alternatiivkommunikatsiooni abivahendi kasutamine;
 - võimalusel keskkonna kohandamine;
 - lapse vajaduste ja eripäradega tutvumine ja nendega arvestamine, kui ees seisab pikem protseduur või koostöö;
 - esmane lühike kohtumine enne protseduure, kui ees seisab pikem protseduur või koostöö;
 - pikema protseduuri või koostöö puhul (nt krooniliste haiguste puhul) spetsiaalse piktogrammi või piktogrammide loomine tegevusterapeudi või logopeediga, mis aitab lapsel aru saada, mis teda ees ootab.
- **Raskemate probleemsete käitumiste korral on vaja välja töötada toimivad alternatiivsed lahendused koostöös meditsiini-asutustega – nt ravimiga toetamine, visiit koduses või muus turvalises keskkonnas jne. Ei ole mõeldav, et erivajadusega inimene jääb aastateks arstiabita, mistõttu äärmuslik kahjustav käitumine intensiivistub.**
- Info lapse diagnooside kohta võiks olla kättesaadav eriarstide ja spetsialistide vahel. Kindlasti ei ole hea lapsevanemal lapsest ja tema haigustest ning seisunditest rääkida ikka ja jälle uuesti, laps seda kõike pealt kuulamas.
- Alternatiivsed autistile sobivad võimalused tuleks välja töötada ka teiste ametiasutuste puhul, näiteks sõrmejälgede andmine isikut tõendava dokumendi saamiseks.

4. ÕPPE KOHANDAMISEGA SEOTUD BAASVAJADUSED

Sarnaselt kõikide teiste lastega peab õppe- ja kasvatustegevus nii lasteaia kui ka koolis lähtuma kaasava hariduse põhimõtetest (vt rohkem [Mõlema silme pimedus - Õppe kohandamisega seotud vajadused](#))

- **Sotsiaaltransporditeenus.** Sõitmist tuleb hakata harjutama varakult, keerulisematel perioodidel koos tugiisikuga. Vajadusel tuleks kohandada keskkonda: keerata raadio vaikseks või panna kinni, juht ei räägi telefoniga, väga häälekas ja rahutu laps ei sõida liiga suure hulga teiste lastega koos, sõit olgu paraja pikkusega jne.
- Lapse lasteaeda või kooli jõudmine või mittejõudmine ei ole vaid pere vastutus – see on jagatud vastutus ja **haridusasutuse kohustus on perega pidevalt koostööd teha.**
- **Alternatiivkommunikatsiooni vahendid:** piktogramm, kommunikaator, lihtsustatud viiped vms.
- **Meeli rahustavad abivahendid:** sõltuvalt vajadusest kõrvaklapid, tumedad prillid, närimiskaelakee, raskustekk, raskusvest, spinner, pallid, hüppepall, kuppeltoolid, tunnetustuba, sensoorse integratsiooni tuba jne. Need on olulised ka koduses keskkonnas ja spetsialistid saavad peret toetada erinevate võimaluste tutvustamisega.
- **Kohandatud koolikeskkond:** väikeklass, toetav ja rahulik interjäär, alternatiivkommunikatsiooniga märgistatud selge funktsiooniga esemed ja kohad, rutiin.
- Muudest diagnoosist tulenevate abivahendite vajadust hindab ja vastava abivahendi määrab abivahendite spetsialist.

5. LISAINFO

- Eesti Autismiliit: www.autismiliit.ee
- SA Autistika: autistika.ee
- Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus: henk.ee
- Alternatiivkommunikatsiooni maailm: tegevuste.ee/alternatiivkommunikatsiooni-maailm
- Verge metoodikast – turvaline sekkumine füüsilise agressiooni korral: www.verge.ee/materjalid
- Infopunkt omastehoolduse teemadel, sh hooldusvajadustega laste toetamine (teenused, abivahendid, haridus, jõustavad kogemuslood): www.omastehooldusest.ee

5.1. KASUTATUD ALLIKAD

- Rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon – RHK-10 – psüühika- ja käitumishäired valisveeb.kliinikum.ee/psyhhaatriakliinik/lisad/ravi/RHK/RHK10-FR17.htm

Downi sündroom

1. TERVISESEISUNDIST ÜLDISEMALT

Downi sündroom (DS) on kõige sagedasem kromosoomihaigus, mis põhjustab intellektipuuet (loe rohkem peatükist [Intellektipuu](#)). Downi sündroomi korral on lapsel üks lisakromosoom.

Peaaegu kõigil DS-iga inimestel diagnoositakse haigus kohe pärast sündi, kuna neil lastel on mitu tüüpilist tunnust. Tavaliselt on neil lastel silmade välisnurk ülespoole viltuse lõikega, väike ümmargune pea, lame näoprofil. Esineb kolmas silmalaug ehk epikantus, mis kujutab endast silmanurgas asuvat iseloomulikku nahavolti. Sageli on neil lastel ka lihaste toonus madalam ja liigesed üliliikuvad. Lisaks omapärasele välimusele võib kaasneda palju suhteliselt raskeid meditsiinilisi probleeme, mistõttu vajavad DS-iga inimesed regulaarset meditsiinilist kontrolli.

Kui tekib DS-i kahtlus, siis tuleb see kinnitada kromosoomianalüüsiga. Kromosoomianalüüs tehakse veeniverest ja selle analüüsi alusel saadakse kindel diagnoos. Soovituslik on nõustada perekonda küsimuses, kui suur on tõenäosus, et ka järgmine laps võib sündida DS-iga. Samuti võiks nõustada DS-iga lapse õdesid-vendi antud haiguse osas – st kas õdedel-vendadel võib esineda geneetiline risk DS-ga lapse sünniks. Täpne diagnoos ja haiguse põhjused on vajalikud ka puude raskusastme vormistamiseks ning individuaalse arenguprogrammi koostamiseks.

Kõigile rasedatele pakutakse raseduse ajal vereseerumi sõeluuringut. Selle uuringu käigus määratakse kaks või kolm näitajat, mille alusel arvutiprogramm ütleb, kui suur on raseda tõenäosus sünnitada DS-iga laps. Kui risk on suur, siis pakutakse täiendava uuringuna loote kromosoomianalüüsi. Kui peres on juba üks DS-iga laps, siis järgmise raseduse korral lisandub naise vanuseriskile veel umbes 1%.



2. SUHTLEMINE DOWNI SÜNDROOMIGA LAPSEGA

Suhtlemissoovitused DS-iga lapse osas on üldjoontes samasugused nagu intellektipuudega laste puhulgi (vt [Intellektipuude](#) peatükki). DS-iga laste intellektitase võib varieeruda peaaegu normintellektist kuni sügava intellektipuudeni.

Lisaks arvesta järgmist:

- DS-iga lapsel võib nägemispuudest tulenevalt olla suhtlemine keerulisem.
- DS-iga laste reaktsioonid võivad olla aeglasemad, mistõttu vajavad nad suhtlemiseks piisavalt aega.
- Kasuta alternatiivset kommunikatsiooni, mis aitab lapsel vestlusest paremini aru saada.
- Hea kontakti eelduseks on rutiinne päeva- ja nädalakava.
- Lapsed on enamasti sotsiaalsed ja sõbralikud, mis võib kontakti loomist lihtsustada, kuid nad võivad olla ka "jäärpäisemad" ja otsusekindlamad võrreldes intellektipuudega lastega.
- Intellektipuudega lapsel on alati lihtsam sinust aru saada, kui teil on vahetu kontakt, ta näeb, kuuleb sind ja ta saab kasutada oma meeli.

3. KUIDAS TOETADA DOWNI SÜNDROOMIGA LAST JA TEMA PERET?

3.1. RAVI JA MEDITSIINILINE JÄLGIMINE

DS-ile ei ole ravi, kuid oluline on ravida sündroomiga kaasnevaid terviseprobleeme ja sümptomeid. Sageli esineb südame- ja seedetrakti kaasasündinud ebatavalisi arenguid, mille ravi on kirurgiline.

DS-iga inimestel võivad elu jooksul areneda mitmed haigused, näiteks tsöliaakia, kilpnäärme alatalitus (hüpotüreoos), nägemis- ja kuulmislanguus. **Oluline on haiguste varajane avastamine ja regulaarne jälgimine, et alustada ravi võimalikult varakult ja parandada elukvaliteeti.** DS-iga inimesed võivad vajada sagedasemat meditsiinilist kontrolli, kuid tihti jäävad nad erinevate terviseprobleemide suhtes aladiagnoosituks, sest sümptomid võivad olla mittespetsiifilised või vähem märgatavad.

3.2. PRAKTILISED SOOVITUSED TERVISHOIUTÖÖTAJALE:

- **Aita vanematel teadvustada kaasuvate haiguste võimalust ja vajadusel suuna pere vastavate spetsialistide juurde.**
- DS-iga vastsündinutele on **kohustuslik südame ultraheliuuring**, kuna kliinilise läbivaatuse ja EKG-ga võib jääda osa kaasasündinud südameriketest avastamata.
- Kasuta DS-iga lastele mõeldud **spetsiaalseid kaalu- ja kasvukõvera**id.
- Jälgi regulaarselt **kilpnäärme funktsiooni** (TSH ja T4 määramine iga kahe aasta tagant).
- Uuri **regulaarselt tsöliaakia esinemise võimalust**, nt iga kahe aasta tagant.
- **Jälgi regulaarselt nägemist ja kuulmist**, kuna häired võivad jääda märkamatuks ning mõjutada käitumist.
- Ole teadlik **uneapnoe riskist**, mida põhjustavad ülekaal ja DS-iga seotud anatoomilised iseärasused. Kahtluse korral suuna uneuuringutele.

3.3. LAPSE JA PERE TOETAMINE

DS-iga lapse sünd toob peresse alati kriisiolukorra, mis nõuab hoolikat ja teadlikku lähenemist. Keskne on varajane sekkumine ja regulaarne, mitmekülgne tugi, mis aitab perel toime tulla ja lapse arengut toetada.

Praktiline tugi perele võib hõlmata:

- psühholoogilist nõustamist ja kogemusnõustamist;
- regulaarset lapsehoiu- või tugiisikuteenust, et vanemad saaksid tööl käia, puhata ja tegeleda ka pere teiste lastega;
- rahaliste toetuste ja rehabilitatsiooniteenuste pakkumist. Rehabilitatsiooniteenuste roll on õpetada last tulema toime igapäevaeluga (söömine, riietumine, hügieen). Osa DS-iga lapsi suudavad õppida lugema ja kirjutama. Kasulik on ka ravivõimlemine ja massaaž, et tugevdada nõrka lihaskonda.
- nõustamist ja tuge igapäevastes ülesannetes;
- lapse integreerimist tavakeskkonda, võimaldades tal mängida eakaaslastega ja käia tavarühmas või tavakoolis (vajaliku abiga).



Varajase sekkumise võtmeks on ka **vanemlike oskuste toetamine**, et laps saaks areneda maksimaalselt oma igapäevaelu keskkonnas:

- **Laps areneb igapäevategevusi tehes ja matkides.**
- Positiivse minapildi tekkimiseks on **oluline last tunnustada**.
- Lapse **tunnete märkamine ja nende nimetamine**.
- Suhtlemis- ja igapäevaoskuste kujundamine **positiivse sõna** abil.
- **Liikumisharjumuste** tekitamine, näiteks igapäevane jalutamine, ujumine, võimlemine. Juhendatud sporditegevuse võimalusi uurida Eriolümpia Eesti Ühendusest, kus pakutakse sportimisvõimalusi intellektipuudega lastele ja noortele, või Eesti Paralümpiakomiteest, kes toetab erivajadusega noori neile sobivas tippspordis.
- Kõik igapäevased tegevused imikuga (lahti riietamine, riidesse panemine, jne) peavad kulgema viisil, mille käigus lapsega rahulikult vesteldakse ja räägitakse toimuvast („Nüüd paneme sokid jalga ... üks jalg ... hästi, nüüd teine.“).
- **Peenmotoorika arendamine on oluline selleks, et laps õpiks kasutama oma sõrmi peenemates ja suuremat täpsust nõudvates tegevustes.** Nendeks on nii söömine, kirjutamine kui ka joonistamine, samuti enda eest hoolitsemine, näiteks nööpide kinni panemine ja lahti tegemine; alates kolmandast eluaastast noa ja kahvliga söömine jne.
- Lapse **päeva- ja nädalarütm** – siin on olulised toetavad, aga kindlad reeglid.

4. ÕPPE KOHANDAMISEGA SEOTUD BAASVAJADUSED

Õppekava valikul kehtivad sarnased põhimõtted nagu intellektipuudega laste osaski (vt [Intellektipuue - õppe kohandamisega seotud vajadused](#)) ja üldisemad põhimõtted (vt [Mõlema silma pimedus - õppe kohandamisega seotud vajadused](#)).

5. LISAINFO

- Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit: vaimukad.ee
- Downi Sündroomi Ühing: [Facebooki grupp](#)
- Infopunkt omastehoolduse teemadel, sh hooldusvajadustega laste toetamine (teenused, abivahendid, haridus, jõustavad kogemuslood): www.omastehooldusest.ee
- Alternatiivkommunikatsiooni maailm: tegevuste.ee/alternatiivkommunikatsiooni-maailm
- Eesti Agrenska Fond: www.agrenska.ee
- Eesti Eriolümpia Ühendus – toetab intellektipuudega inimeste sportimisvõimalusi: eeo.ee
- Eesti Paralümpiakomitee – erivajadustega inimeste tippsport, sh liikumisharjumuste propageerimine erivajadustega inimeste hulgas: www.paralympic.ee

Vähidiagnoosid

1. TERVISESEISUNDIST ÜLDISEMALT

Kui täiskasvanutel mängivad vähivormide puhul rolli elustiiliga seotud riskitegurid, siis lapsepõlves esinevate vähkkasvajate puhul seda väita ei saa. Lastel tekivad kasvaja enamasti **juhuslike geenimutatsioonide tulemusel** ilma päriliku eelsoodumusega.

Ohtlik on kokkupuude kiirgusega, seda on seostatud teatud tüüpi lapseea vähivormidega. On võimalik, et näiteks vanema suitsetamine suurendab riski teatud vähivormide tekkimiseks tema lapsel. Osa pahaloomuliste kasvaja – nagu Wilmsi kasvaja, neuroblastoomi, sugurakkude ja mõnede ajukasvajate – rakud võivad beebil olla juba sündides. Lastel esinevad väga varasest rakustaadiumist tekkinud kasvaja, enamasti on tegemist looteeest pärinevate hävimata jäänud rakkudega, mis hakkavad kontrollimatult paljunema, moodustades nn kasvajamassi, mille üldnimetuseks on blastoomid.

Onko- ja hematoloogilise diagnoosi vanuserühmas 0–18 aastat kinnitab Eestis ainult laste hematoloog-onkoloog. Pahaloomuliste kasvajatega lapsi ravitakse Eestis kahes keskuses: Tallinna Lastehaiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Eestis diagnoositakse lastel aastas vähki keskmiselt 35 uut juhtu vanuses 0–14 aastat ja 40 uut juhtu vanuses 15–24 aastat.

Laste (0–14 aastat) ja noorte (15–24 aastat) kasvaja näol on tegemist väga harva esinevate haigustega, mille sagedus suureneb Eestis ca 0,5% aastas. 15–24-aastastel noortel ette tulevad vähid on enamasti sarnased lapseeas esinevatega, kuid esinevad ka täiskasvanutele iseloomulikud vähitüübid, näiteks kartsinoomid. Noorukite vähielulemus on võrreldes lastega lühem.

Lapseea kasvaja on harvikaigus ehk haigus, mille esinemissagedus on vähem kui 5 juhtu 10 000 inimese kohta.

Ehkki Eestis paraneb üle 80% vähihaigetest lastest, võib vähihaigus lõppeda surmaga.

Kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja lastel on äge lümfoblastne leukeemia – seda esineb ca 31% kõigist pahaloomulistest kasvajatest lastel (8 last aastat). **Järgmised sagedasemad pahaloomulised kasvaja on kesknärvisüsteemi kasvaja, lümfoomid, neuroblastoomid, neerutuumorid, luukasvaja.** Kaks peamist primaarset luukasvajat lastel on osteosarkoom ja Ewingi sarkoom.

2. SUHTLEMINE VÄHIHAIGE LAPSEGA

Vähki põdev laps vajab erilist lähenemist ja seetõttu on oluline luua temaga usalduslik ja toetav side. Suhtlemisel tuleb arvestada, et teatud ravimite kõrvalmõjud tekitavad lapses tema tahte ja mõistusele allumatuid käitumisviise (näiteks ärevus, ärrituvus, väsimus, tujude kiire muutumine).

Praktikas tähendab see:

- **Pööra tähelepanu lapse emotsioonidele ja kehakeelele.** Kui ta on väsinud, ärev või ei soovi rääkida, luba tal puhata ja võta ühendust hiljem.
- Vähihaige laps võib vajada **rohkem aega ja ruumi oma tunnete väljendamiseks**. Ole rahulik ja kannatlik, näidates, et oled tema kõrval igal sammul.
- **Räägi lapsega tema enesetundest**, küsi, mis teda aitab ja mis mitte. Anna talle **võimalus ise väljendada**, mida ta vajab või soovib.
- **Välgi eakohatut keerulist meditsiinilist juttu**, kasuta lapse jaoks arusaadavaid sõnu ja selgitusi.
- Näita, et oled valmis kuulama ja toetama; **kuula tähelepanelikult**, mida laps räägib ja märka, kuidas ta end tunneb.
- Paku lapsele **turvalist ruumi**, kus ta saab end vabamalt väljendada ja olla tema ise.
- Kui laps on selleks valmis, proovi kasutada **mängu ja kunstilisi tegevusi**, et aidata tal väljendada oma tundeid ja luua positiivseid kogemusi.
- **Annad lapsele julgustust ja positiivset energiat**, aidates tal tunda end toetatuna.
- Paku lapsele kindlust ja rutiini, mis aitab tal **tunda end turvaliselt ka keerulistes oludes**.
- Julgusta, lähtudes muidugi tema tervislikust seisundist, last osalema sotsiaalsetes tegevustes ja suhtlema sõpradega, et **säilitada sotsiaalsed sidemed ning aidata hoida ja toetada tema identiteeti**.
- Toeta lapse motivatsiooni ja **positiivset suhtumist õppimisse**, tunnustades saavutusi.

3. KUIDAS TOETADA VÄHIHAIGET LAST JA TEMA PERET?

Vähki haigestunud laps vajab mitmekülgset ja individuaalset toetust, et tagada tema heaolu ning aidata toime tulla ravi ja haigusega seotud proovikividega. Üldiseid eetilisi põhimõtteid lapse ja pere toetamisel saad lugeda [ametniku eetika peatükist](#). Kui info vähihaige lapse kohta on sündmusteenuse ja automaatse andmevahetuse kaudu jõudnud kohaliku omavalitsuse laste heaolu spetsialistini, on oluline perega ühendust võtta.

Praktikas tähendab see:

- Perele **ennetava toe pakkumist**, abivõimaluste tutvustamist. Vähki haigestunud lapse pere hakkamasaamine sõltub väga suurel määral tervishoiu ja omavalitsuse poolt pakutavatest **teenustest**. Lapse vähidiagnoosiga kaasneb pikaks ajaks haiglasse jäämine. **Pere jaoks tähendab diagnoosi saamine kriisi ning on suur oht sattuda toimetulekuraskustesse, sh saada tõrjutud välja tööturult**. Vähihaigus on **aegkriitiline**, sest laste kasvajad on tavaliselt agressiivsed ja nõuavad väga kiiret reageerimist.
- **Pakkuda koduhooldusteenuseid, rehabilitatsiooniprogramme, psühholoogilist nõustamist, mis aitavad perel paremini haigusega kohaneda ning parandada lapse ja pere elukvaliteeti**. Laps võib tunda, et hoopis tema peab toetama oma vanemaid ja olema vapper, et vanemad ei oleks kurvad. Seetõttu peab ka laps saama haigusega kaasnevaid negatiivseid emotsioone turvaliselt väljendada.
- **Toetada pereliikmeid, kes hoolitsevad haige lapse eest, pakkudes neile psühholoogilist nõustamist ja kriisi maandamise võimalusi**. Näiteks võib jagada perele infot Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidust (EVLVL), kes saab olla toeks vähihaigetele lastele ja nende peredele.
- **Tagada perele sobivad rahalised toetused**, mis aitaksid katta tervishoiu- ja hoolduskulusid ning toetaksid pere toimetulekut; näiteks kulub vähihaigete laste peredel palju ravimitele, mähkmetele ja transpordile.
- Julgustada ja **toetada pere ümberkorraldusi kodus ning elukeskkonnas**, et see oleks parem ning turvalisem lapse tervises seisundist tingitud vajadusi silmas pidades.

3.1. TEENUSED

Pakutavad teenused võivad olla väga erinevad, olenevalt lapse haiguse raskusastmest ja pere toimetulekust. **Oluline on, et kriisis perele pakutaks tuge ennetavalt**. Samuti on oluline koostöö tervishoiutöötajate, haridustöötajate ning sotsiaal- ja hooldusasutuste vahel, et pakkuda lapsele parimat võimalikku hooldust ning elukvaliteeti.

Praktikas võib see tähendada, olenevalt perest ja lapsest:

- Psühholoogilise nõustamise ja psühhoteraapia pakkumist, sh grupiteraapia.
- Rehabilitatsiooniteenuste pakkumist, sh toetavaid teraapiaid (muusika-, kunsti-, loovteraapia).
- Toitumisspetsialisti nõustamist.
- Koduhooldusteenust – tuge söömisel ja joomisel (sonditoitmine).
- Tugiisikuteenuse pakkumist ja korraldamist.
- Koduõendusteenust.
- Palliatiivravi, hospiitteenuse osutamist kodus.

3.2. ABIVAHENDID

Olenevalt lapse haigusest võivad osutada vajalikuks erinevad liikumisabivahendid (käru, rulaator, kargud, ortoosid jm), prillid, kuuldeaparaadid, ravimid ja hooldusvahendid (näiteks pikaaegne kateeter, infusiooniseadmed, toitmissondid, aspiraatorid), diagnostilised ja raviseadmed (kaasaskantavad hingamisaparaadid), mida soovitab vastava eriala spetsialist (arst, rehabilitatsioonispetsialist).

4. ÕPPE KOHANDAMISEGA SEOTUD BAASVAJADUSED

Oluline on meeles pidada, et **iga laps on ainulaadne ning vajab personaalset lähenemist**. Koostöö, paindlikkus ja lapse toetamine aitavad tagada parima võimaliku hariduskogemuse raske haigusega võitlemise hetkedel. **Vähihaige lapse õppe kohandamise juures on oluline maksimaalne paindlikkus nii õppekava kui ka -keskkonna osas**. Idee võtta lapsele vaheaasta ei ole esimese soovitusena sobiv, kuna lapsele on oluline liikuda oma klassikaaslastega koos edasi ja kuuluda endiselt sinna, kuhu ta kuulus enne haigestumist.

Praktikas tähendab see, et:

- Lapsele ja perele tuleb **pakkuda võimalust õppida kodus või haiglas**, kasutades veebipõhiseid õppevahendeid.
- **Muuta õppe sisu ja õppekeskkonda** vastavalt lapse tervislikule seisundile – paindlikum õppeaeg, lühemad õppetunnid, vajadusel distants- või koduõpe.
- Vajalik on **lapse õppimisvõime pidev hindamine ja jälgimine** ning individuaalse õppekava ja täiendava toe pakkumine (näiteks eripedagoogiline tugi, logopeedid, teraapiad), sh realistlik ajakava, päevaplaan, mis arvestab lapse terviseseisundit ja raviskeemi.
- Tagada **avatud ja regulaarne suhtlus** kooli, lapsevanemate ning tervishoiutöötajate vahel, et koordineerida vajalikud kohandused ning jälgida lapse arengut.
- **Toetada lapse sotsiaalsust ja emotsionaalset heaolu**, pakkudes võimalusi sõprussuhete loomiseks ning enesehinnangu toetamiseks – näiteks osaleda ühisüritustel ja suhelda eakaaslastega.
- Tagada kooli ja õpikeskkonna **ligipääsetavus** ning sobivad ained ja vahendid.
- **Psühholoogilise toe pakkumine** lapsele ja pereliikmetele, et aidata toime tulla haigusega ning õppimisega seotud proovikividega. Vajadusel kaasata kooli nõustaja või psühholoog.

PRAKTILINE NÕUANNE KOOLILE:

Õpetaja ülesanne on selgitada klassikaaslastele ja nende vanematele kaasõpilaste tervise seisundit, et juuksed kaotanud laps ei satuks kiusu ohvriks või teda ei tõrjutaks kartuses, et haigus on nakkav. Samuti on oluline jagada teadmisi, et ravi ajal paigaldatud veeniport ei tohi saada põrutusi ega lööke. Eesti Vähiliidu kodulehelt leiab lihtsas keeles materjale lastele ette lugemiseks või nendega koos lugemiseks, aitamaks aru saada, mida üks või teine vähi diagnoos endast kujutab: cancer.ee/trukised

5. LISAINFO

- **Eesti Vähiliit:** www.cancer.ee
- **Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit:** www.vahilapsed.ee
- **Rahvusvaheline Lapseea Vähi Organisatsioon:** <https://www.iccd.care>
- **Infopunkt omastehoolduse teemadel, sh hooldusvajadustega laste toetamine** (teenused, abivahendid, haridus, jõustavad kogemuslood): www.omastehooldusest.ee

5.1. KASUTATUD ALLIKAD

- **Eesti Vähitõrje Tegevuskava:** <https://bit.ly/3TMWaeO>
- **Maailma Tervishoiuorganisatsioon:** www.who.int
- **Regionaalhaigla: Röntgenkiirgus – mida patsient peab teadma:**
www.regionaalhaigla.ee/sites/default/files/documents/2024-10/R%C3%B6ntgenkiirgus_regionaalhaigla_0.pdf

